

赤脚医生手册



广东省梅县专区革命委员会
中国人民解放军广东省梅县军分区 合编

赤脚医生手册

(内部发行)

广东省梅县专区革命委员会合编
中国人民解放军广东省梅县军分区

一九七〇年九月

赤脚医生手册

广东省梅县专区革命委员会合编
中国人民解放军广东省梅县军分区

广东省梅县印刷厂印刷

1970年9月第1版

印数00001—50000册

(内部发行)

青年人民服務

毛澤東

救死扶傷實川

革命的人道主義

10月1日

團結新走中西各部分
醫藥衛生工作者，組成
鞏固統一戰線，為開展
偉大的人民衛生工作
而奮鬥！
毛澤東

道夜神：云
白景东

何？甜^甜解^解
人^人走^走夫^夫美^美产^产美^美味^味息^息
唱^唱云^云（生^生地^地川^川）
入^入系^系。四^四天^天通^通看^看一^一
何。生^生活^活日^日日^日
① 夜^夜神^神了^了。一^一样^样
进^进来^来到^到也^也波^波

没^没生^生“[“]苦^苦重^重烟^烟
将^将天^天建^建石^石筑^筑
很^很细^细茂^茂地^地
牛^牛马^马河^河流^流穿^穿
地^地下^下河^河流^流穿^穿
挖^挖。河^河口^口夜^夜无^无光^光
心^心生^生。就^就
航^航明^明喝^喝天^天
贞^贞光^光。

夜^夜神^神人^人如^如神^神，
记^记下^下天^天下^下。及^及日^日
中^中。河^河流^流穿^穿。夜^夜
① 不^不可^可说^说也^也
排^排照^照。地^地下^下。商^商。是^是
生^生南^南天^天。天^天下^下。希^希

真^真凡^凡得^得何^何系^系系^系
公^公夜^夜神^神州^州安^安舞^舞亮^亮
孔^孔雨^雨四^四倍^倍。翻^翻

公^公夜^夜神^神人^人如^如神^神，
记^记下^下天^天下^下。及^及日^日
中^中。河^河流^流穿^穿。夜^夜

七律二首

送瘟神

一九五八年七月一日

毛泽东

读六月三十日人民日报，余江县消灭了血吸虫。浮想联翩，夜不能寐。微风拂煦，旭日临窗。遥望南天，欣然命笔。

绿水青山枉自多，
千村薜荔人遗矢，
坐地日行八万里，
牛郎欲问瘟神事，

其

春风杨柳万千条，
红雨随心翻作浪，
天连五岭银锄落，
借问瘟君欲何往，

华佗无奈小虫何！
万户萧疏鬼唱歌。
巡天遥看一千河。
一样悲欢逐逝波。

二

六亿神州尽舜尧。
青山着意化为桥。
地动三河铁臂摇。
纸船明烛照天烧。

毛主席语录

领导我们事业的核心力量是中国共产党。

指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。

备战、备荒、为人民。

把医疗卫生工作的重点放到农村去。

应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业。

、我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争。

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高。

毛主席语录

人类总得不断地总结经验，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

我赞成这样的口号，叫做“一不怕苦，二不怕死”。

白求恩同志毫不利己专门利人的精神，表现在他对工作的极端的负责任，对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。

.....

我们大家要学习他毫无自私自利之心的精神。从这点出发，就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小，但只要有这点精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。

前 言

“为什么人的问题，是一个根本的问题，原则的问题。”医疗卫生工作围绕着为什么人的问题，长期以来存在着两条路线的激烈斗争。医疗卫生工作为广大劳动人民服务，是毛主席无产阶级卫生路线的核心，是卫生工作的根本方向。可是叛徒、内奸、工贼刘少奇及其在卫生部门的代理人，却疯狂反对毛主席的无产阶级卫生路线，把医疗卫生工作的重点放在城市中的少数人身上，实际上是为资产阶级服务。伟大领袖毛主席在一九六五年尖锐地批判了刘少奇的反革命修正主义卫生路线，一针见血地指出：卫生部是“**城市老爷卫生部**”，并向广大医务人员发出了伟大号召：**“把医疗卫生工作的重点放到农村去”**。

伟大的无产阶级文化大革命，摧毁了刘少奇的资产阶级司令部，斩断刘少奇伸向卫生部门的魔爪，贫下中农掌握了农村医疗卫生大权，并且遵照毛主席**“什么工作都要搞群众运动”**的教导，把卫生工作和群众运动结合起来，全面地推进了人民的医药卫生事业，使广大农村卫生面貌焕然一新。“赤脚医生”就

是在毛泽东思想哺育下，在两个阶级、两条道路、两条路线的激烈斗争中成长起来的新生事物。她一出现，就得到我们伟大领袖毛主席的热情支持，深受广大贫下中农的衷心爱戴，显示了无限的生命力。这是毛主席的无产阶级卫生路线的伟大胜利。

为了全面落实毛主席“**备战、备荒、为人民**”的伟大战略方针，从“平战结合”出发，做到“平时群防群治，战时群救群医”；为适应广大“赤脚医生”防治疾病的需要，我们以毛泽东思想为指针，在广大工农兵和革命医务人员的热情支持下，在调查研究的基础上，发动群众，集体编写了这本《赤脚医生手册》。本书的编写，力求做到防治结合，以防为主，中西结合，以中为主，土洋结合，以土为主。介绍了除四害、讲卫生，农村常见病、多发病的防治，战地救护、“三防”知识，新医新针疗法，常见草药五百零三种等十章。

由于我们活学活用毛泽东思想不够，对毛主席的无产阶级卫生路线领会不深，加之编写时间匆促，其中错误、缺点在所难免，我们热诚地希望同志们提出宝贵意见，帮助我们进一步修订提高。

一九七〇年九月

编写说明

一、本书第五、九章，介绍了130多种常见病、多发病的防治，每一病的治疗又分针灸、中草药和西医药等疗法，以方便赤脚医生在临症时，根据具体情况，灵活选用。

二、本书第十章选载了中草药503种，其中多数为本地区产量多、疗效较高的常用药物，可以大力推广。但也有一些为有毒、或剧毒的药物，在性味功能一项指出，使用时宜慎加注意。

三、书中所列中草药以本专区多数地区的叫法定为正名，不同的叫法列为别名，但一般名称较为统一的则不另注别名，以免名目繁多，反而增加学习的困难。

四、本书所载中草药剂量，仍按中医传统习惯沿用旧制，每斤16两，每两10钱，每钱10分，折合公制，每钱相当于3.125克。

有些处方，药味少，剂量大，甚至有的带有毒性，使用时需要慎重些，可以参考中药学，从常用量开始，逐步增加，以保证安全。

本书除小儿科和处方有注明者外，一律为成人用量，老、弱、幼儿宜根据实际情况酌减剂量。

五、本书中草药处方，除有注明用“鲜”或捣烂取汁内服或外敷者之外，一般以干品为准。

六、凡使用中草药汤剂者，一般每两药加水150毫升，煮取50毫升，第二煎加水100毫升，煮取30毫升，两次煮出液各于煮后服用，或混合分二至三次服用。

目 录

第一章 除四害、讲卫生、 消灭疾病……………(1)

第一节 坚决贯彻毛主席
“预防为主”的
伟大方针，大搞
群众性的爱国卫
生运动……………(1)

第二节 除四害……………(2)

灭老鼠……………(2)

灭蚊……………(3)

灭蝇……………(4)

灭臭虫……………(5)

附：灭蟑螂……………(6)

第三节 讲卫生……………(6)

饮水卫生……………(6)

饮食卫生……………(10)

粪便无害化处理……………(11)

工业卫生……………(12)

第四节 消灭传染病

常识……………(14)

传染病的传播……………(14)

控制和消灭传染病

措施……………(15)

第二章 人体的基本结构 和生理……………(21)

第一节 运动系统……………(23)

第二节 循环系统……………(28)

第三节 呼吸系统……………(33)

第四节 消化系统……………(37)

第五节 泌尿系统……………(39)

第六节 生殖系统……………(41)

第七节 神经系统……………(42)

第八节 感觉系统……………(45)

第九节 内分泌系统……………(47)

第三章 中医学基本知识(49)

第一节 人与自然……………(49)

第二节 阴阳……………(50)

第三节 五行……………(51)

第四节 脏腑 附气血……………(52)

第五节 诊断要点……………(55)

第六节 辨证纲要……………(59)

第七节 治法方药……………(64)

第四章 诊断学基础……………(70)

第一节 问诊……………(70)

问诊要求和注意事项(70)

问诊内容……………(70)

第二节 体格检查……………(72)

体格检查方法……………(72)

一般检查……………(73)

头颈部检查……………(74)

胸部检查……………(74)

腹部检查……………(80)

泌尿生殖系统检查……………(82)

神经系统检查……………(82)

第五章 常见病的防治……………(84)

第一节 常见急诊处理(84)

高热……………(84)

惊厥……………(85)

昏迷……………(86)

休克……………(88)

呼吸困难……………(89)

心力衰竭……………(90)

咯血.....(92)	第四节 内科疾病... (129)
呕血.....(93)	急性支气管炎..... (129)
急性腹痛.....(93)	慢性支气管炎..... (130)
氰化物中毒.....(95)	大叶性肺炎..... (131)
有机磷农药中毒.....(95)	肺脓肿..... (132)
大茶药中毒.....(97)	支气管哮喘..... (133)
毒蛇咬伤.....(98)	急性胃肠炎..... (134)
电击伤.....(99)	溃疡病..... (134)
溺水..... (100)	急性节段性肠炎... (136)
中暑..... (100)	高血压病..... (136)
第二节 传染病..... (101)	急性肾炎..... (138)
感冒及流行性感冒 (101)	慢性肾炎..... (140)
流行性腮腺炎..... (102)	肾盂肾炎..... (141)
流行性脑脊髓膜炎 (103)	肾结核..... (142)
流行性乙型脑炎... (106)	泌尿系结石..... (143)
疟疾..... (107)	前列腺炎..... (144)
麻疹..... (108)	睾丸炎..... (144)
白喉..... (110)	贫 血..... (145)
百日咳..... (111)	偏头痛..... (147)
细菌性痢疾..... (112)	坐骨神经痛..... (148)
阿米巴痢疾..... (113)	神经衰弱..... (149)
传染性肝炎..... (114)	糖尿病..... (151)
附:肝硬化..... (115)	风湿性关节炎..... (152)
肺结核病..... (117)	第五节 小儿疾病... (154)
伤寒..... (118)	蚕豆病..... (154)
钩端螺旋体病..... (119)	小儿夏季热..... (155)
麻风病..... (120)	小儿上呼吸道炎... (156)
第三节 寄生虫病... (122)	支气管肺炎..... (157)
蛔虫病..... (122)	鹅口疮..... (158)
钩虫病..... (124)	臀 红..... (158)
蛲虫病..... (125)	水 痘..... (159)
中华分支睾吸虫病	脊髓灰质炎
(中华肝吸虫病) (126)	(小儿麻痹症) ... (160)
丝虫病..... (128)	急性消化不良
	(婴儿腹泻) (161)

第六节 外科疾病…	(164)
疔……………	(164)
痈……………	(165)
手指化脓性感染…	(166)
烧伤……………	(168)
擦伤……………	(171)
骨折……………	(172)
关节脱位……………	(173)
鸡眼……………	(174)
冻疮……………	(174)
昆虫螫伤……………	(175)
鼠咬伤……………	(176)
化脓性骨髓炎……	(176)
血栓闭塞性脉管炎	(177)
急性腹膜炎………	(178)
急性胆囊炎………	(179)
急性阑尾炎………	(179)
肠梗阻……………	(180)
腹腔空腔脏器穿孔	(181)
痔……………	(181)
脱肛……………	(183)
破伤风……………	(184)
狂犬病……………	(186)
肿瘤……………	(187)
第七节 五官科疾病	(191)
眼病……………	(191)
急性结膜炎……	(191)
麦粒肿……………	(192)
沙眼……………	(192)
角膜溃疡………	(193)
眼外伤……………	(194)
白内障……………	(195)
青光眼……………	(196)
耳病……………	(197)

外耳道疖、外耳	
道炎……………	(197)
化脓性中耳炎…	(198)
鼻病……………	(199)
慢性鼻炎………	(199)
鼻窦炎……………	(200)
鼻出血……………	(201)
咽喉、口腔病……	(202)
扁桃体炎………	(202)
慢性咽喉炎……	(202)
龋齿……………	(203)
复发性口疮……	(204)
皮肤病……………	(204)
农业皮肤病……	(204)
湿疹……………	(205)
癣……………	(206)
荨麻疹……………	(207)
神经性皮炎……	(208)
接触性皮炎……	(209)
脓疱疮……………	(210)
带状疱疹………	(210)
附 部分制剂方…	(211)
片剂……………	(211)
丸剂……………	(213)
散剂……………	(216)
酒剂……………	(219)
糖浆剂……………	(220)
合剂……………	(221)
膏剂……………	(224)
洗剂……………	(225)
擦剂……………	(225)
注射剂……………	(226)
第六章 常用操作……	(228)
第一节 体温、脉搏、呼	
吸和血压测量	
方法……………	(228)

第二节	消毒与灭菌	(229)	第十一节	捏脊法	… (273)
第三节	皮内、皮下、 肌肉和静脉 注射方法	… (230)	第十二节	卤硷疗法	(273)
第四节	静脉输液	… (232)	第八章 战地救护和 三防	… (277)	
第五节	常用药物过 敏试验	… (234)	第一节	战地救护	… (277)
第六节	洗胃法	… (235)	止血	… (277)	
第七节	灌肠法	… (236)	包扎	… (280)	
第八节	肛管排气法	(238)	骨折的临时固定	… (282)	
第九节	导尿法	… (238)	在火线上搬运伤员 的方法	… (285)	
第十节	人工呼吸与 心脏按摩	… (239)	第二节	核武器、化学 武器和细菌武 器的防护	… (288)
第七章 新医疗法	… (242)		原子武器损伤的防 护和急救	… (288)	
第一节	新针疗法	… (242)	化学武器损伤的防 护与急救	… (291)	
一、新针疗法特点	(242)		细菌武器的防护 措施	… (294)	
二、具体操作	… (242)		第九章 妇产科常见病 与计划生育	… (295)	
三、针刺意外情况 的处理	… (243)		第一节	概要	… (295)
四、禁忌症	… (244)		女性生殖器解剖和 临床特点	… (295)	
五、疗程	… (244)		月经生理及保健	… (296)	
六、常用穴位	… (244)		第二节	妇科常见病	(297)
第二节	灸法	… (261)	月经不调	… (297)	
第三节	耳针疗法	… (262)	功能性子宫出血	(297)	
第四节	鼻针疗法	… (264)	闭经	… (298)	
第五节	手针疗法	… (265)	痛经	… (298)	
第六节	拔罐疗法	… (268)	白带过多	… (299)	
第七节	水罐疗法	… (269)	滴虫性阴道炎	… (300)	
第八节	割治和挑治 疗法	… (269)	盆腔炎	… (300)	
第九节	埋(植)线 疗法	… (271)	急性盆腔炎	… (300)	
第十节	穴位注射 疗法	… (271)			

慢性盆腔炎……	(301)
子宫脱垂……	(301)
第三节 妊娠与分娩	(302)
妊娠生理和	
妊娠保健……	(302)
妊娠中毒病……	(306)
早期妊娠中毒病	(306)
晚期妊娠中毒病	(306)
妊娠期出血……	(307)
流产……	(307)
葡萄胎……	(310)
宫外孕……	(310)
前置胎盘……	(311)
胎盘早期剥离……	(311)
子宫破裂……	(312)
产后出血……	(312)
新法接生……	(314)
产褥感染……	(317)
乳汁过少……	(318)
乳腺炎……	(318)
第四节 计划生育……	(319)
提倡晚婚……	(319)
避孕……	(319)
人工流产……	(321)
绝育术……	(321)
第十章 中草药……	(322)
第一节 中草药知识	(322)
怎样认药……	(322)
描写植物形态常用	
名词图解……	(323)
一、一般名称……	(323)
二、根……	(324)
三、茎……	(324)
四、叶……	(324)

五、花……	(326)
六、果实……	(326)
怎样采药……	(327)
第二节 常用中草药	
(503种)……	(328)
一、辛凉解表药……	(328)
二、辛温解表药……	(345)
三、清热解毒药……	(356)
四、清热凉血药……	(396)
五、清热利湿药……	(418)
六、化痰止咳药……	(441)
七、清肝利胆药……	(461)
八、清热利水渗	
湿药……	(469)
九、祛风除湿药……	(485)
十、活血祛瘀药……	(518)
十一、收敛固涩药	(550)
十二、止血药……	(556)
十三、止痛药……	(567)
十四、补益药……	(579)
十五、消导、驱	
虫药……	(593)
十六、蛇虫咬伤药	(600)
十七、外用药……	(608)
附一、常用中药……	(637)
二、中医常用成	
药成方……	(650)
三、常用西药……	(659)
四、常用中草药	
正、别名笔	
画索引……	(733)
五、常用中草药	
学名索引……	(759)

第一章 除四害、讲卫生、消灭疾病

第一节 坚决贯彻毛主席“预防为主” 的伟大方针，大搞群众性的爱 国卫生运动

预防为主还是重治轻防，是卫生战线两个阶级、两条道路、两条路线斗争的重要体现。我们的伟大领袖毛主席十分关心广大人民群众的健康，在1945年就指出：“……所谓国民卫生，离开了三亿六千万农民，岂非大半成了空话？”

“应当积极地预防和医治人民的疾病，推广人民的医药卫生事业”。1952年又教导我们：

“动员起来，讲究卫生，减少疾病，提高健康水平”。1958年7月1日，毛主席写了光辉诗篇《送瘟神》二首，给全国人民以极大鼓舞。1965年6月26日，毛主席又对卫生工作作了划时代的极为重要的指示：

“把医疗卫生工作的重点放到农村去。”这一系列伟大指示给医疗卫生工作指出了根本的方向。可是，叛徒、内奸、工贼刘少奇长期以来推行反革命修正主义医疗卫生路线，重医

轻防，重城市轻农村，对抗毛主席的无产阶级革命卫生路线，破坏广大劳动人民的卫生防病工作，犯下了滔天罪行。

我们无限忠于毛主席，誓死捍卫毛主席的无产阶级革命卫生路线，坚决贯彻毛主席“预防为主”的伟大方针，用毛泽东思想统帅卫生预防工作，彻底肃清刘少奇反革命修正主义卫生路线的流毒，批判“重治轻防”的错误思想，在党的领导下，发动并依靠广大革命群众，轰轰烈烈，踏踏实实地深入持久地开展爱国卫生运动，做好防病工作，为提高我国人民的健康水平而努力奋斗。

开展除害灭病为中心的爱国卫生运动，是贯彻“预防为主”方针的根本措施，是关系移风易俗，改造世界的大事，是落实毛主席“要准备打仗”的伟大指示，“粉碎敌人的细

菌战争”的伟大战略措施。

开展爱国卫生运动，要遵循毛主席“我们必须告诉群众，自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争”的教导，依靠当地党委，充分发动群众，依靠群众，大作宣传，大造声势，做到家喻户晓，人人动手，打一场除害灭病的人民战争。要狠抓阶级斗争和路线斗争，肃清叛徒、内奸、工贼刘少奇及其代理人所散布的“四害除不了”的谬论和“物质刺激”、“形式主义”等修正主义的余毒，要紧密结合生产，结合防治主要疾病，讲求实际效果。

开展爱国卫生运动，要狠抓重点，狠抓制度落实和狠抓典型。水粪管理问题较多的地区，就应发动群众迅速改变面

貌；在春初夏中，要广泛开展以除害灭病为中心的爱国卫生运动；夏季着重预防肠道传染病和流行性乙型脑炎、疟疾等病；双抢季节注意防治中暑、稻田皮炎和钩端螺旋体病等。狠抓制度的落实就是要使爱国卫生运动成为经常化，树立“讲卫生为革命，为革命讲卫生”的新风尚，逐步建立合理的、行之有效的各项卫生制度。在经常性的卫生工作基础上，一年中要大抓四次，每季一次，充分发动群众，开展以除害灭病为中心的爱国卫生大突击运动，定为常例，坚持下去，年年如此。要树立先进，及时总结经验，及时推广，开展比学赶帮活动，把爱国卫生防病工作不断向前推进。

第二节 除 四 害

灭 老 鼠

老鼠的危害很大，不但可以传染鼠疫、钩端螺旋体病，而且可以造成许多重大的经济损失。如盗食粮食、蔬菜，损坏禾苗、树种，栖息河堤引起决口，发生水灾，破坏建筑物而缩短建筑物的寿命，毁坏衣服和书籍等。所以，必须大力

消灭它。

灭鼠方法：

消灭老鼠要突击和经常相结合反复地进行，有步骤地采取防鼠、捕鼠、毒鼠、毁窝等多种多样的办法。

（一）防鼠：消除老鼠生活条件，断绝鼠粮，堵塞鼠洞。

（二）捕鼠：使用鼠夹、鼠笼等各种捕鼠工具和方法来

捕鼠。

(三) 毒鼠：利用毒药灭鼠。常用的毒鼠药有磷化锌和安妥等，应交替反复使用。

磷化锌毒鼠，一般制成含量2—5%的毒饵，取谷物95—98份加适量的油（或用加有3%糖的4%淀粉糊代替），搅拌使谷物沾一层油液，然后再加入2—5份的磷化锌，搅拌到均匀散布在谷物表面上为止（制磷化锌毒饵，最好不要用易变酸的食物去配制，以免使毒饵易失效）。

用安妥毒鼠对人较为安全，一般用1—3%含量的毒饵，可用面粉或米粉制成团，

每公斤面团毒饵切成五百枚。

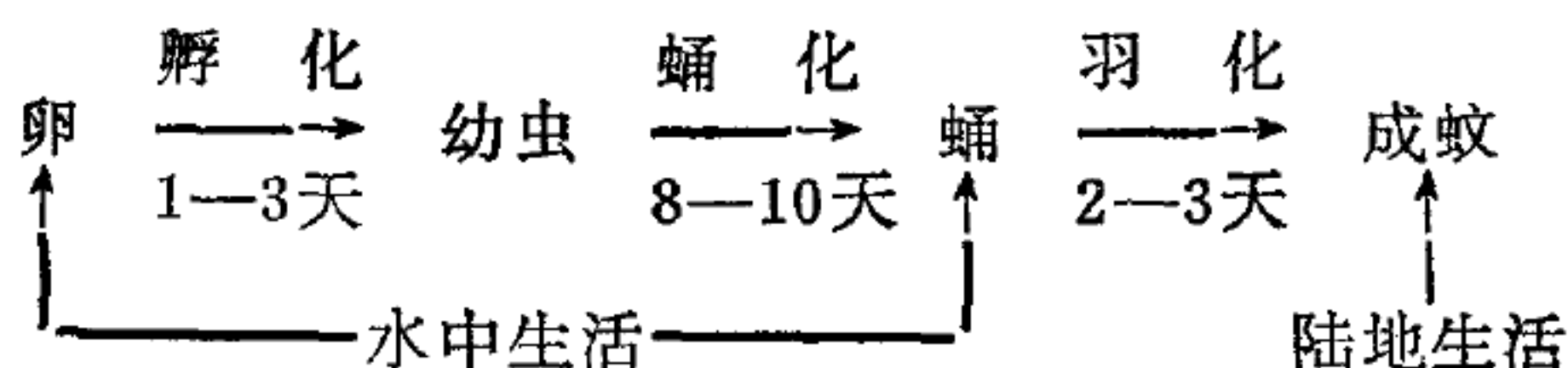
仓库及下水道可用硫磺燃烧时产生二氧化硫，经过6至8小时而将鼠熏死。（每立方米空间用硫磺70—100克）。

(四) 毁窝：凡是可能有鼠的地方要经常检查，发现鼠洞，随时毁掉或堵塞。

灭蚊

蚊子是在所有医学昆虫中最重要的毒虫，它传染疟疾、丝虫病和流行性乙型脑炎等疾病，严重地影响人类的健康。

蚊子的生活史，主要经过四个阶段即：



蚊子的繁殖力很强，在炎热的气候，自卵发育成蚊仅需7—10天。

灭蚊方法：

(一) 消灭孳生地：处理孳生地是灭蚊的根本措施。发动群众填平洼地积水、疏通沟渠、整修街道、改明沟为暗沟，毒杀孑孓等方法。

用药物毒杀孑孓可用：

1. 取辣蓼草鲜草一斤，加热水半斤，浸4小时投入粪坑

或污水中，可杀蛆或孑孓。

2. 取闹羊花茎叶捣碎和水浸渍成水溶液，可以喷洒杀灭孑孓，也能灭蛆。

3. 毛茛全草切碎后投入粪坑或水坑，能杀孑孓及蛆。

4. 用0.1%敌百虫溶液喷洒（或泼洒），每平方米用量40毫升。

(二) 杀灭成蚊，主要是发动群众进行网捕、扑打和药物灭蚊。

药物灭蚊的方法：

1.人住房与畜舍滞留喷洒法：在疟疾和丝虫病严重流行的地区，在蚊虫密度高峰到来之前，用“二二三”（又名DDT）或“六六六”粉配成5%的溶液，用喷雾器均匀地喷洒在墙壁上，每平方公尺面积喷药量要达到纯“二二三”2.5克，“六六六”纯丙体180—240毫克。持续效能“二二三”约二个月，“六六六”约一个月，所以用“二二三”要隔两月喷洒一次，用“六六六”要隔月喷洒一次。

2.熏杀：采用“六六六”烟剂或效果确实的土烟剂如辣蓼草、烟杆、除虫菊、桉树叶等，结合当地情况，定时定点在室内室外施用。在蚊虫大量繁殖季节，采用大规模烟海战术，可使成蚊密度下降。烟熏灭蚊应在同一时间，统一行动，于傍晚进行。“敌敌畏”是一种熏杀效果极强的有机磷杀虫剂，用“敌敌畏”原油放在一铁皮盒内加热挥发，关闭门窗约30分钟，对蚊、蝇、蟑螂、臭虫均有杀灭作用。用“敌敌畏”来灭蚊蝇用量，每间房（五十立方米）仅用0.25毫升原油即可。或用“敌敌畏”乳剂加水5000倍，喷在房间地板上，每间房喷药一斤稀

释液亦有熏杀作用。“敌敌畏”对人畜均有毒性，使用时应注意安全。

（三）防蚊：晚上睡觉挂好蚊帐，或房间设纱窗、纱门，尽量减少蚊虫叮咬的机会。点燃蚊香驱蚊效果也好。牲畜体大，气味重，容易引诱蚊子，所以提倡人畜分居。

灭 蝇

苍蝇为伤寒、霍乱、痢疾等肠道传染病的媒介。它的繁殖力很强，一生需经卵、幼虫（蛆）、蛹和成虫四个时期的变化。一般7—10天可繁殖一代。苍蝇产卵孳生的地方很多，主要有粪便、垃圾和腐败的动物组织。在农村孳生最甚的地方是猪粪，在城市则主要是孳生于垃圾中。蛆钻入泥土化蛹越冬，为苍蝇第二年接代繁殖的主要方式，南方成蝇也可过冬，因此冬、春挖蛹灭蝇对降低全年苍蝇密度有重要的意义。

灭蝇方法：

（一）控制和消灭孳生地：结合积肥，大搞环境卫生，消灭苍蝇孳生场所，这是消灭苍蝇最根本的方法。垃圾用泥封堆积作肥料，禽畜粪便经常清理，猪屎缸、厕所要加盖，或建无害化厕所，必要时也可以用药物控制。方法是：50%敌

百虫溶液一汤匙加水10市斤可喷10—20只粪缸，或10—20平方米的面积，或可用6%“六六六”可湿性粉撒在粪缸表面，每只缸撒15—30克。农村水厕既孳生苍蝇又孳生蚊子，可结合积肥施放一些有杀虫效果的辣蓼和闹羊花等（方法见灭蚊节）。

（二）杀灭成蝇：在消灭孳生地的同时，还必须发动群众杀灭成蝇。可采用扑打、捕蝇器及药物等方法。

药物灭蝇：

1. 百部一两熬汁，再和砂糖拌匀，诱蝇食即死。

2. 夹竹桃叶适量捣取鲜汁，拌在食物中（约含10%）诱杀苍蝇。

3. 把诱饵（饭粒、鱼肠等）盛在盘内，加上0.1—0.2%敌百虫或0.1%敌敌畏溶液2~3汤匙诱杀苍蝇。

4. 在多蝇场所，可用50%敌百虫2毫升，红糖半两，加水2市斤喷在苍蝇停息的地方。或用0.1—0.2%敌百虫溶液或敌敌畏乳剂喷洒，也可擦抹或泼洒。

5. 敌敌畏熏蒸灭蝇，见“灭蚊”节。

灭 臭 虫

臭虫对人体危害是叮咬吸

血，妨碍人们正常睡眠休息，降低工作能力，此外还能引起抓伤和皮肤病。

臭虫的发育经卵、稚虫、及成虫三个时期，当食料充足，温度在27—30°C时，由卵至成虫约三十天。成虫寿命很长，可活六、七个月至一年之久，能耐饥饿，成虫可饿至一年不死，稚虫可饿六、七十日，主要宿主为人类，在饥饿时也吸取鸟血、鼠血，常喜潜伏于木器缝隙内。

臭虫的活动范围一般只是在人居住的寝室中，但在公共场所桌椅中也往往有臭虫，臭虫可由衣、被、火车、船、飞机等携带散布。

灭臭虫方法：

（一）开水烫杀法：用开水从床板及器具的裂缝内灌浇进去。

（二）填塞法：用桐油石灰等嵌料将室内墙缝、地板缝和床架等处缝隙全部填塞，使臭虫不得出入。

（三）日光暴晒：衣服、被褥、草蓆经常放到日光下暴晒，并经常翻动晒物。

（四）水浸法：将床板桌凳等家具浸泡在池塘中五天，使臭虫溺死。

（五）药物杀灭法：用敌百虫和“敌敌畏”效果最好。用

0.5—1%敌百虫溶液喷洒在臭虫栖息的场所，每平方公尺喷25—50毫升，或用5%敌百虫粉剂喷撒，每平方公尺喷5—10克，或可用五千分之一的“敌敌畏”溶液来喷洒。

此外，用苦楝树叶铺在蓆子下，也可消灭臭虫。

附：灭蟑螂

蟑螂喜欢在厨房等存放食物的地方活动，不但贪吃东西，传染伤寒、结核、蛔虫等病，还能咬坏书籍、皮箱等，必须予以消灭。

(一)消灭孳生地：厨房及存放食物的地方，经常保持清洁。用石灰堵塞蟑螂躲藏繁殖的裂缝。

(二)捕杀蟑螂：

1.断绝蟑螂食物：妥善收藏食物，清除食物残渣，可把蟑螂饿死。

2.瓶捕：选择小口径的玻璃瓶，在瓶内存放香味食物，瓶口四周涂油，蟑螂诱进瓶后就无法爬出。

3.毒饵诱杀：用硼砂一份，面粉一份，加少许糖调匀做成大如黄豆的丸子，撒在蟑螂经常活动的地方，可把蟑螂毒死。或将芙蓉叶捣烂，加糖少许，拌和均匀，或配成1—2%敌百虫食饵，引诱蟑螂食后毒死。

4.药物喷杀：结合消灭蚊蝇，用敌敌畏、敌百虫、二二三、六六六等药物喷洒在蟑螂活动和孳生的场所。

第三节 讲 卫 生

饮 水 卫 生

水是人和一切生物维持生命的要素，但往往又是霍乱(付霍乱)、伤寒、痢疾、传染性肝炎等肠道传染病传染的重要途径，因此供人饮用的水质好坏，对人健康关系极大。

饮用水质的卫生要求：不含各种病原菌和寄生虫卵；不含对人有害的化学物质；水质

要澄清，无特殊气味。

水质要达到卫生要求，必须从选好水源、保护水源和净化消毒入手。

(一)水源选择。地下水(井水、泉水)经过地层过滤作用较地面水(河水、溪水、塘水、水库水)污染程度小些，因此适合打井地区最好采用打井取地下水，而且井水容易保护，具有战备意义。有山

泉的地区引用山泉水作为饮用水就更为理想。近年来，各地采用河中潜井作为自来水水源效果良好。

(二)水源保护。饮用水源要防止被污染和放毒。河水的汲水处和自来水取水点，应选择在污水、污物的排放口及运输垃圾、粪便码头的上游。亦可采取功能分段、分时间取水办法。对饮用的塘水禁止倾倒垃圾、粪便、污水等污物，保持塘四周的清洁。井水的保护，首先井的位置要选好，位置要避免选在积水及低洼沼泽地带和厕所周围。井越深越好，地面结构要严密，井壁不漏水，防止地面水渗入，要有高出地面的井栏，每年最好能掏挖一次水井。(见图1—1)

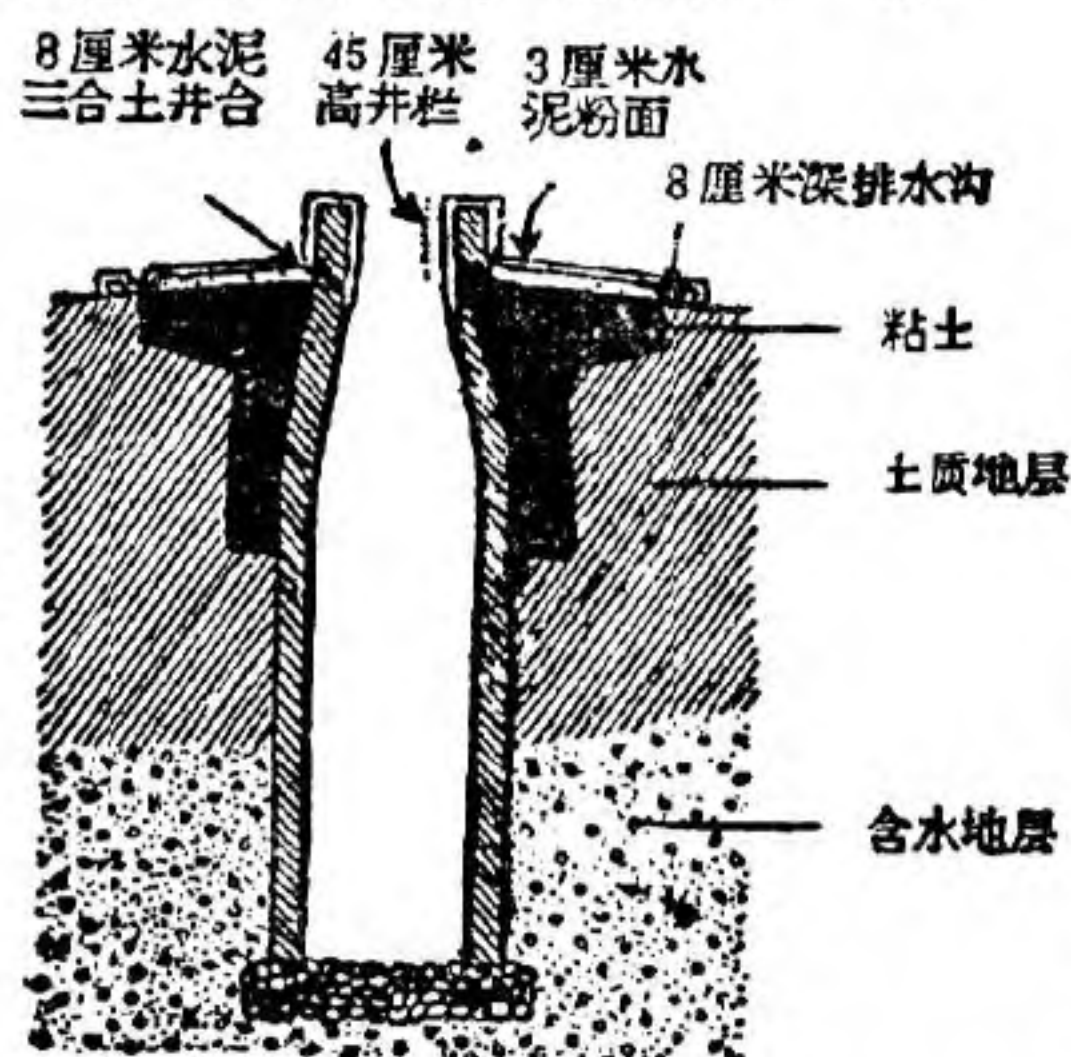


图 1—1 水井示意图

(三)水的净化和消毒。

1. 水的净化：常用的办法

是沉淀和过滤。沉淀又分自然沉淀和凝集沉淀，自然沉淀对水中微小的混悬颗粒效果较差，而凝集沉淀效果较好。凝集沉淀常用凝集剂有明矾，用量一般是按10担水加半两计算，加入溶解后，充分搅拌，不久杂质沉淀，水质变清，如果杂质不能沉淀，可加石灰少许，加速杂质下沉。为了清除水中经过凝集仍未被凝集的浮游物，在凝集沉淀后还须进行过滤，使水通过砂层，把细小的浮游物阻留于砂层表面内。

砂滤池滤料排列如图1—2

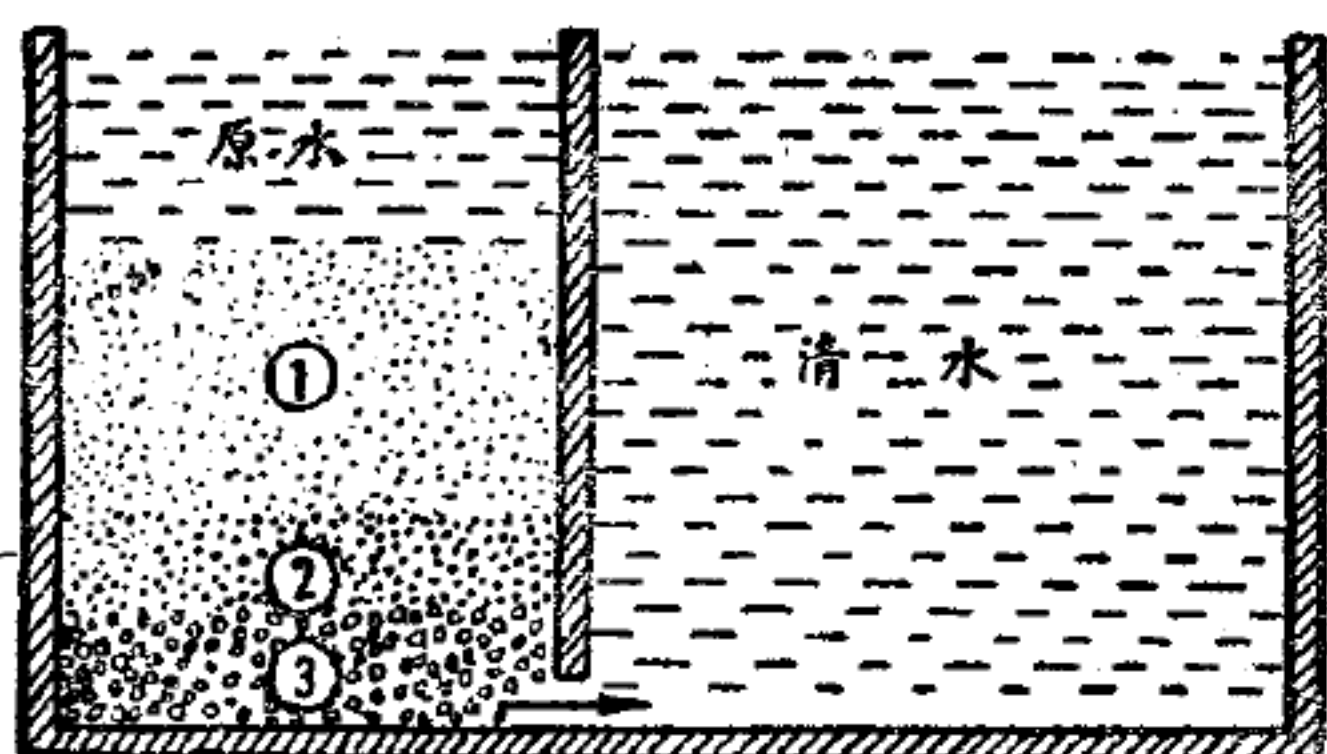
其中细砂层是过滤净化的主要材料，对水质净化起绝对作用。

过滤池最好有二池轮换使用，保证供水不断。

2. 水的消毒。原水经过凝集、沉淀、过滤处理后，细菌并不能全部清除，还须进行消毒处理，特别是在有肠道传染病流行的地区和季节要进行消毒。消毒的方法很多，煮沸消毒是最好最简便的方法，应教育群众不喝生水，此外经常应用的是氯化消毒法，常用的氯化消毒剂有漂白粉和漂粉精片或粉。

漂白粉有效氯含量在25—35%间。漂粉精片(粉)有效氯含量较高，约在60—70%

图 1—2 砂滤池剖面图



①细砂层80~120公分厚

②粗砂层10~15公分厚

③碎石层15~30公分厚

注：1. 砂滤池过滤面积的大小计算：
使用人数 $\times 0.016$ 平方米。

2. 过滤池到清水池出水口的大小约为过滤面积的2~5%。

3. 滤池底要有集水结构，可用砖条排成有规则的1—2厘米宽的纵横方向缝隙，条条引向清水池方向。

左右，二者化学性质都不稳定，高温、光线、水份都易使它们分解，故保存时应避光、防潮、严密封口放于阴处，现配现用。

(1) 缸水消毒。

直接加药法：使用漂粉精片，每担水加一片，或加漂粉精粉专用塑料小匙一小平匙，如用明矾沉淀过的水，可每二担加一片，或加漂粉精粉一小平匙。加药时先将漂粉精片放在碗里研碎，加水调成糊状，倒入缸内搅动，半小时后饮用。如使用漂白粉消毒，可取新鲜

漂白粉半斤，加水5斤充分调和，沉淀24小时后取上层清液，即成10%的漂白粉澄清液，装入有色的玻璃瓶或其它密封容器内备用。使用时每担水加澄清液一匙（约10毫升），经过明矾沉淀的每二担水加澄清液约10毫升。

(2) 井水消毒。

直接加氯消毒法：

这种方法，每天至少在水用前半小时要消毒一次，如能做到每日消毒二次（早晨与中午，或中午与傍晚各一次）效果更好。

水井中加漂白粉的用量（克），可根据井内水面的宽度（直径）和水面至井底的深度（水深）从表1—1查出。

找出应加漂白粉量后，用汤匙取药（每匙约10克），将漂白粉置于碗中，加水少许调成糊状，倒入井中震荡，消毒半小时后就可使用，一般要求余氯在0.2—0.5毫克/升间。

二节式竹筒持续消毒法：用粗5—6厘米二节相连的竹筒一个，上面一节作浮筒，下面一节开一活门，宽约4厘米作为加药用，在活门下方打三、四

个小孔（直径4毫米），此处为竹筒可装250—300克（半市斤
氯溢出孔（见图1—3）。一般左右）漂白粉，使用时将漂白

圆井井水消毒漂白粉用量表 表1—1

井直径 (市尺) 水深 (市尺)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	
1	0.5	1.5	2	3	4	5.5	7	8.5	10.5	12.5	
1.5	1	2	3.5	4.5	6.5	8.5	10.5	13	16	19	
2	1.5	3	4.5	6.5	8.5	11.5	14	17.5	21.5	25.5	
2.5	2	3.5	5.5	8	10.5	14	17.5	21.5	26.5	31.5	
3	2.5	4	6.5	9.5	12.5	17	21	26	32	37.5	
3.5	3	5	8	11	15	20	25	30.5	37.5	44	
4	3	5.5	9	12.5	17	22.5	28	34.5	42.5	50	
4.5	3.5	6	10	14	19	25.5	32	39	48	56.5	
5	4	7	11	15.5	21	28.5	35.5	43.5	53.5	63	
5.5	4.5	7.5	12	17	23	31	39	47.5	58.5	69	
6	4.5	8	13.5	19	25.5	34	42.5	52	64	75.5	
6.5	5	9	14.5	20.5	27.5	37	46	56.5	69	82	
7	5.5	9.5	15.5	22	29.5	39.5	49.5	60.5	74.5	88	
7.5	6	10.5	16.5	23.5	31.5	42.5	53	65	79.5	94	
8	6	11	18	25	34	45	56.5	69.5	85	100.5	
8.5	6.5	11.5	19	26.5	36	48	60	73.5	90.5	106.5	
9	7	12.5	20	28	38	51	63.5	78	95.5	113	
9.5	7.5	13	21	30	40	53.5	67	82.5	101	119.5	
10	8	13.5	22	31.5	42	56.5	70.5	86.5	106.5	125.5	

注：1.水深及井直径如与表中数值略有差异，可取近似值。

2.方井可依本表应加漂白粉量增加百分之二十（即用1.2乘之）。

3.水深超过10尺者，可分成两个数字找表，应加量为两数之总和，如14尺水深之井可找10尺及4尺两数合计。

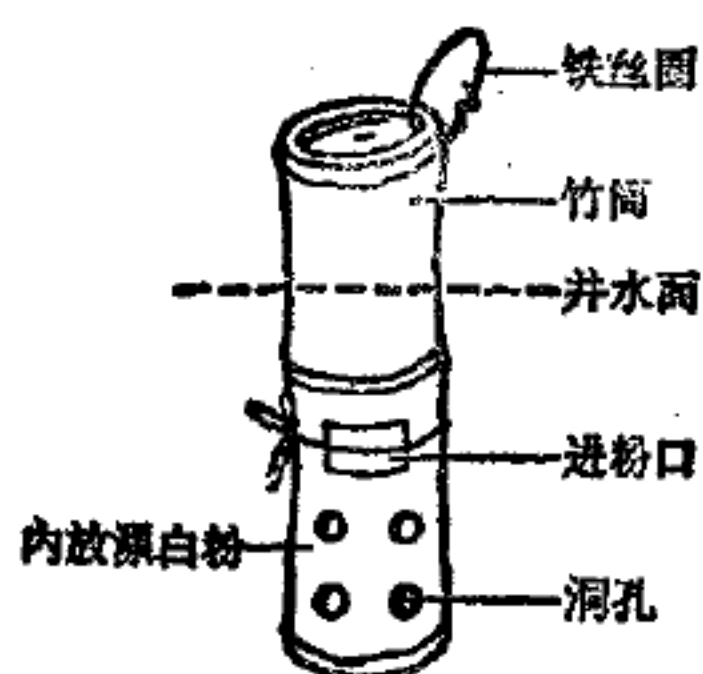


图1—3二节式竹筒持续消毒器

粉自活门装入筒内（不必加水搅拌），然后盖好活门并用塑料线扎住，即可放入井中，随着吊水时的震荡，氯气不断溢出。用水量多氯溢出量也多。一次加药，一般可持续消毒

7—10天左右，冬天更长一些。

凡使用持续消毒法，都应测定余氯以鉴定消毒效果，准确地控制加药数量和保持有效时间。水经过常氯量消毒后20—30分钟（夏季20分钟，冬季30分钟），应测定余氯。一般加甲士立丁测定。也可直观测定（见表1—2）。凡能嗅出氯臭而不具较强刺激时，表示余氯适量，约在0.2—0.5毫克/升间。若不易嗅出氯臭，表示余氯过低，若氯臭具较强刺激时，表示余氯过高，约在0.7—2毫克/升以上。

余氯测定法表 表1—2

水中余氯量毫克/升	加甲士立丁后颜色	氯 臭 程 度
0.1	淡 黄	仅 可 嗅 出
0.2	黄 色	容 易 嗅 出
0.5	明显黄色	有 明 显 氯 味
0.7—1.0	深 黄	氯 味 大
2.0以上	棕 黄	有强烈刺激性

饮 食 卫 生

食品由于含有水分和营养物质，容易受到外界环境中物理的、化学和生物学的影响而变质或腐败，微生物在食品中生长繁殖，是食品腐败变质的最主要原因，处理不当，容易

发生食物中毒和肠道传染病而危害人体健康，影响生产，因此必须做到：

1. 注意做好食品保藏，不食腐败变质的食物。

2. 不吃有毒的动植物。如河豚鱼、蟾蜍的内脏和皮、毒覃等都有毒，不可食用。某些

含毒薯豆类如木薯、狗爪豆、发牙的马铃薯等必须经过去毒处理，才可吃用。

3. 要做好食品加工和饮食行业的卫生管理。饮食行业食品要防蝇、防蟑螂、防鼠和防尘，食具要消毒。炊事和饮食服务人员要进行卫生常识教育，做好个人卫生，发现有肺结核、伤寒、痢疾等传染病要进行隔离治疗，或调离接触熟食品工作。

4. 宣传群众改变某些生吃习惯。吃“鱼生”最容易传染华支睾吸虫病。沙门氏菌食物中毒往往是吃了未煮透的含有沙门氏菌的病畜肉或蛋品所引起，因此肉蛋类要煮熟透吃。

5. 不暴饮暴食。暴饮暴食往往容易使胃肠机能紊乱，易得胃肠疾病。

粪便无害化处理

粪便是肥效很高和使用

最广的有机肥料。但粪便处理不当就会污染外界环境，孳生大量苍蝇，传播多种疾病，对人民健康危害很大；同时大大地损失肥效，影响农业生产。因此，合理地处理粪便在卫生上、防病灭病上和促进农业生产上都有极为重要意义。要从根本上消灭目前在农村常见的钩虫病和蛔虫病，就要对人粪进行无害化处理。

粪便无害化处理的要求是：不污染水源、空气和土壤；不孳生苍蝇和蚊子；杀灭致病菌和寄生虫卵；保存肥效。

厕所是粪便收集、贮存的主要形式，是进行无害化处理的主要环节，如能达到上述要求，粪便无害化问题就基本解决了。

下面介绍一种适合农村的粪封式三池无害化厕所，构造如图1—4。

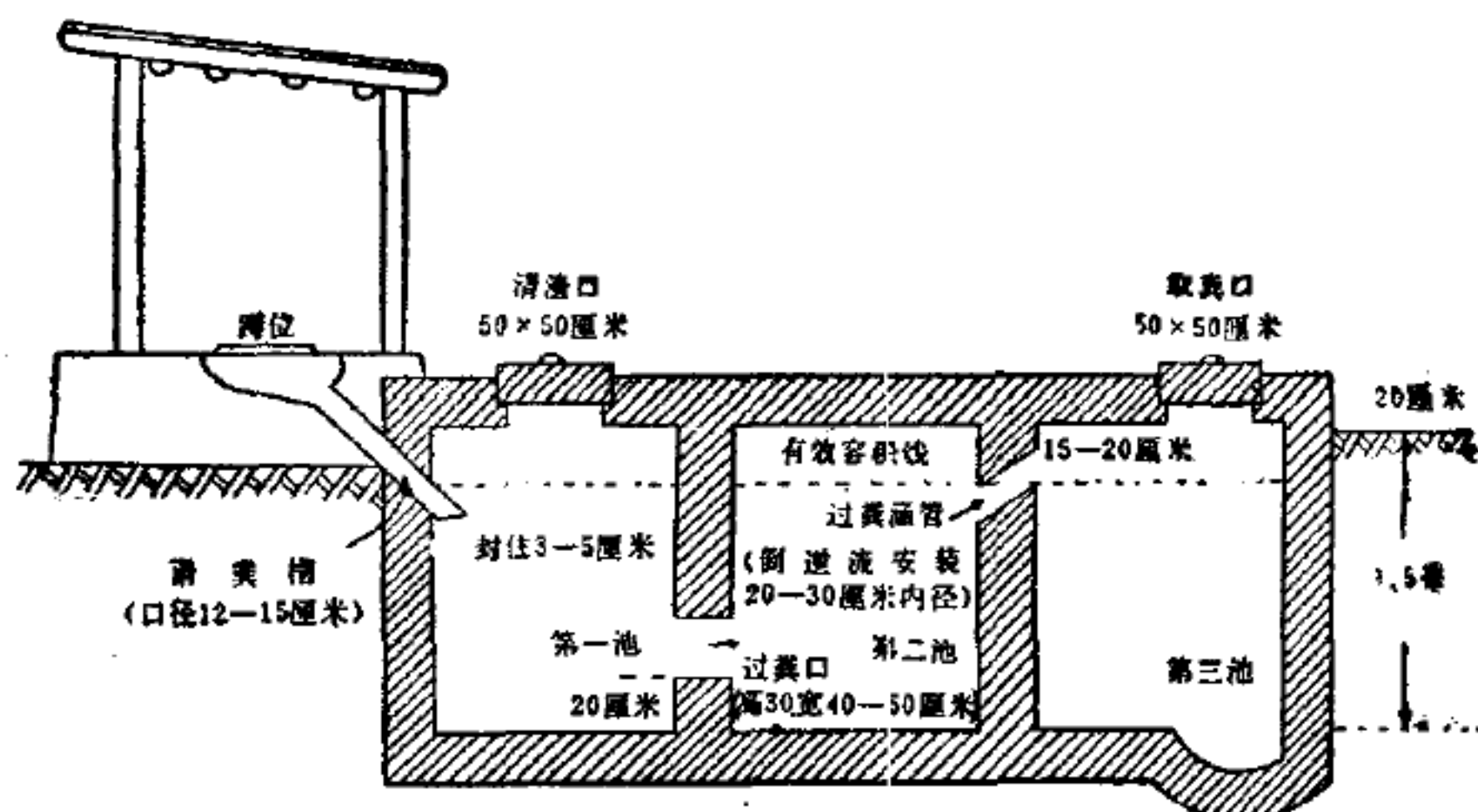


图1—4 粪封式三池无害化厕所剖面示意图

三池无害化厕所无害化原理：

1. 因粪池结构是密封的，不但可以防止蚊蝇的孳生，而且粪便在厌氧条件下，经厌氧菌分解，产生一部分沼气、游离氨等，能杀灭病原菌和寄生虫卵，同时还能减少肥份的损失。

2. 沉淀作用。利用寄生虫

卵比重较液体大的原理，将寄生虫卵除去。实验证明，蛔虫卵经4小时可沉淀99%以上，钩虫卵经24小时可沉淀92%。

在使用人数不多，地下水位低的粘壤地区可采用圆形缸式三池结构，结构简单，造价低。见图1—5。

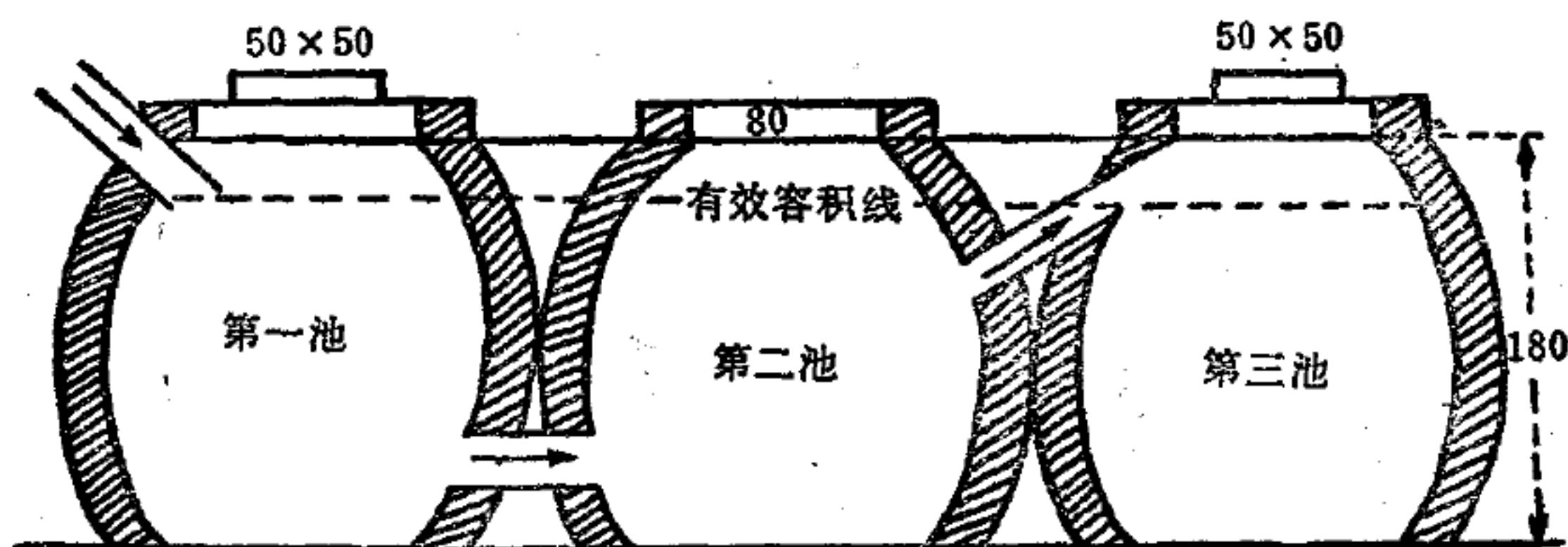


图1—5 缸式三池无害化厕所剖面示意图

根据上述原理，农村可利用旧粪池进行改建以达到无害化处理的目的。

无害化厕所化粪池在发酵分解过程中能产生大量沼气，在取粪和清理粪池时，要防火和防沼气中毒。取粪时要把取粪口打开约1小时，换换气后才可取粪。

工业卫生

在工业生产中，常常产生对工人健康有害的因素，这些有害的因素归纳起来主要有两类：（1）物理因素：如高温，

噪音，高频电，放射线等；

（2）化学因素：各种化学性毒物和粉尘。由于这些因素的作用，可致使工人患上各种与职业有密切关系的疾病，叫做职业病。职业病的种类很多，但危害较大的有：尘肺、职业中毒、中暑及工业性外伤等。

职业病的诊断：具有它的特殊性。是一项十分严肃认真的工作，不仅关系工人的健康问题，还直接关系到国家劳保条例的实施和社会主义制度的优越性问题。医务人员必须十分慎重。因此要采取医生、干

部、工人三结合的诊断方法，综合职业史，临床表现，既往健康状况及实验室检查结果，详细地分析有关材料，作出正确的诊断结论。贯彻“**预防为主**”的方针是做好职业病防治的根本措施。因此必须掌握下列几点原则：

1. 原材料选择：少用或不用有害物质或用无害物质代替。

2. 改进生产技术：采用机械化，自动化，管道化，密闭化和湿式作业生产。

3. 加强通风：合理布置自然通风系统，采取适当的机械通风，厂矿建设应符合卫生要求。

4. 建立必要的防护制度，严格执行安全操作规程，经常检查测定作业场所空气中粉尘浓度和毒物含量，保持不超过国家规定的最高容许浓度。加强个人卫生防护。

5. 执行就业前的健康检查和就业后定期健康检查，早期发现患者，及时治疗和治理。

根据我区当前工业生产情况，简要介绍下列两点防护知识：

一、矿井防尘的综合技术措施

矿井防尘，一般采取下列措施：湿式凿岩，爆破前后洒

水喷雾，装卸车时洒水湿润，设置通风系统，佩戴个人防护用品。其中以湿式作业和通风是最主要的技术措施。

1. 湿式凿岩：要求达到“标准化”，即除要保证水质净化外，还要有足够的水压和风压。凿岩时先水后风，关钻时先风后水。

2. 通风措施：通风是排除矿井中含尘空气的有效措施之一，合理利用自然通风，加强机械通风，防止室内循环风流，设立风门，充分发挥局部通风的作用。

3. 喷雾洒水：最简单有效的措施，无论是在爆破前后或装卸矿车时都要喷洒净水，喷雾洒水主要有两种形式：一种是借压缩空气吹散水点成雾状；一种是直接利用水本身压力喷出。水幕、水帘对防尘效果也很好。

工厂防尘技术措施：

1. 以生产石英砂粉为主的石粉厂，最好采用水磨石英砂法，有困难时则可采取密闭除尘措施。

2. 以石英砂为主要原料的中小型工厂，玻璃、陶瓷应采用湿石英粉为原料，加工过程采用水磨石英，湿粉拌料，湿胚加工；如必需采用干石英粉作为原料时，应先加水湿润，

加强车间内喷雾洒水，密闭除尘。

3. 耐火材料中防尘技术措施，主要采取密闭除尘法，加强车间内的通风。

4. 机械制造厂的喷砂、翻砂，最好推行以铁砂代替矽砂，水中爆破清砂法等。

二、防暑降温

应采取综合措施。包括组织措施，技术措施，保健措施三个方面。

1. 组织措施：加强领导，有专人负责，加强宣传使人人重视，合理安排作业时间和劳动组织，早上班，晚下班，延长中午休息时间等。

2. 技术措施：包括降热，

自然通风和机械通风等。

①降热：是防止幅射热对人体的危害，一般采用水帘，水幕，降热板（降热墙），搭凉棚等方法。

②自然通风：加强通风换气。建设风楼（厂房屋脊两旁的排气设备）风屏，挡风板等。

③机械通风：采用送风风扇和喷雾风扇加强工作面的通风，降低操作场所的温度。

3. 保健措施：包括饮水制度，保健食品供应，个人防护用具和职工的健康检查。大量饮用盐开水和清凉饮料，对高温作业工人很有好处。

第四节 消灭传染病常识

传染病是指有传染性的疾病。都是由一种特殊的病原体（病毒、立克次氏体、细菌、螺旋体、原虫和蠕虫等）所引起的。

传染病如不及时的预防和治疗，就能迅速的传播开来，可严重地影响人民健康和生产。

传染病的传播

传染病的传播由传染源、传播途径和易感者三个环节所

构成。

传染源：是受感染又有病原体生存繁殖并向体外散播的人或动物。传染源有的是有症状的病人（或病动物），有的是无症状的健康病原携带者。

以动物作为传染源的有鼠疫、狂犬病、钩端螺旋体病等。

传播途径：病原体进入健康人的路径，一般有如下几种。

接触传播：接触病人（动

物)或病人用过的用具而得的,叫接触传播。如狂犬咬人传染狂犬病,与沙眼病人共用毛巾、脸盆易得沙眼。

空气传播:分飞沫传播和灰尘传播。呼吸系传染病都可通过飞沫传播,当病人呼气、说话、特别是咳嗽、打喷嚏的时候,从鼻咽部喷出含有病原体的粘液和唾液的飞沫,人吸进后就可能被感染。某些耐干燥的病原体随飞沫或痰落在地上,干后可随尘土飞扬起来而被吸入人的呼吸道,如结核病主要是靠这种方式传播。

水和食物的传播:肠道传染病病人的排泄物污染了水和食物,人们饮用了污染的生水或食物而得病的。如伤寒、霍乱、痢疾等。

虫媒传播:通过吸血昆虫吸了病人或病兽的血后,再叮咬健康人,把病原体带到健康人体内而得病的。如疟疾、丝虫病、乙型脑炎、鼠疫等。

易感者:病原体进入人体后,要看身体对它有无免疫力,无免疫力的就易得病而称为易感者。易感者增多了,流行机会就多起来。

控制和消灭传染病措施

控制传染源,切断传染途径,保护易感者是控制传染病

流行的重要环节。遵照毛主席关于“我们必须告诉群众,自己起来同自己的文盲、迷信和不卫生的习惯作斗争”的教导,依靠群众,发动群众,贯彻以防为主、防治结合的方针,积极开展群众性的爱国卫生运动,养成人人讲卫生,家家爱清洁的良好习惯,是预防和消灭传染病的根本措施。

1.控制传染源。对传染病人要做到早发现、早报告、早隔离(见表1—3)、早治疗;对发现的健康带菌者进行卫生教育和管理,病人的密切接触者被传染和带菌的可能性最大,要加强观察,加强预防注射或进行预防服药。对人有传染的动物病如炭疽病,要做好病畜处理,平时要注意做好牲畜饲养的卫生管理,圈猪积肥预防钩端螺旋体病。要消灭有害动物老鼠。

附:疫情报告制度:

我省规定应报告的传染病分为甲、乙两类,共24种。

甲类:鼠疫、霍乱、付霍乱、天花。

乙类:白喉、麻疹、百日咳、流行性感冒、流行性脑膜炎、猩红热、痢疾(杆菌痢与原虫痢)、伤寒及付伤寒、脊髓灰白质炎、传染性肝炎、流行性乙型脑炎、恙虫病、钩

端螺旋体病、狂犬病、炭疽病、斑疹伤寒、回归热、出血热、波状热、森林脑炎、疟疾。

发现甲类传染病立即报

告，愈快愈好，最慢不能超过一天，乙类传染病不能超过三天。

几种传染病的隔离要求

表1——3

病名	最短最长潜伏期 (常见潜伏期)	传染源	传染途径	隔离时间	接触者检疫 或观察时间
鼠疫	数小时~12天 (3~6天)	啮齿动物	鼠蚤叮咬	治愈后检血三次，肺鼠疫检痰六次阴性	6天
霍乱、副霍乱	数小时~7天 (2~3天)	病人、带菌者	水、食物、苍蝇、手	症状消失，大便培养三次(隔天)阴性	5天
天花	5~16天 (10~12天)	病人	呼吸道	痂皮完全脱落，但不少于发病后40天	14天
细菌性痢疾	数小时~7天 (2~4天)	病人、带菌者	食物、水、苍蝇、手	症状消失，大便培养二次阴性，或体温正常后8天	7天
伤寒、副伤寒	1~42天 (6~14天)	病人、带菌者	水、食物、苍蝇、手	症状消失，粪尿培养各二次阴性，或体温正常后15天	25天
白喉	1~10天 (2~4天)	病人、带菌者	呼吸道	症状消失后2周	10天
百日咳	2~23天 (7~10天)	病人	呼吸道	发病后30天或症状消失	23天
流行性脑膜炎	1~10天 (3~7天)	病人、带菌者	呼吸道	症状消失	10天
水痘	2~21天 (14~16天)	病人	呼吸道	皮疹完全结痂	21天
麻疹	6~21天 (10~11天)	病人	呼吸道	出疹后5天，合并肺炎者不少于发病后10天	21天，经被动免疫28天
流行性感冒	数小时~4天 (1~2天)	病人	呼吸道	症状消失	
流行性乙型脑炎	4~21天 (10~15天)	动物、病人	蚊咬	体温正常	
脊髓灰质炎	3~35天 (7~14天)	病人、带毒者	食物、水、呼吸道	发病后40天	35天
传染性肝炎	14~42天 (21~28天)	病人	食物、水、苍蝇、手	发病后30天(如病情未见好转，应继续隔离)	42天

2. 切断传染途径。就是消灭附着于外界环境物体上或物体内的病原体，并使外界环境健康化，开展以除四害，改善饮水、饮食卫生，以及粪便垃圾无害化处理为主要内容的爱国卫生运动，是切断传播途径的有效措施。

3. 保护易感者。锻炼身体，增强抵抗力，防寒保暖预防感冒，不暴饮暴食。有许多传染病已有特效的疫(菌)苗或类毒素，有计划地开展预防接种增强免疫力，可以达到预防或消灭这些传染病的目的(见表1—4)。

在流行期间，对某些传染病如疟疾、“流脑”等还可以采用预防服药的办法，保护健康人不发病。

预防接种注意事项：

1. 首先根据本大队人口，传染病流行情况，制订预防接种计划，接种时最好采用集中

接种而后分散补种的办法，并做好预防接种登记工作。

2. 接种前必须做好健康情况了解，严格掌握禁忌症(见表1—4)。

3. 严格进行消毒和无菌操作，在接种牛痘、卡介苗时不宜用碘酒。

4. 预防接种后，少数人会出现不同程度的反应：

局部反应——接种后24小时内局部会发生红肿痛现象，严重者可引起局部淋巴结肿痛。

全身反应——主要表现为体温上升，有时伴头痛、寒战、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。

一般轻的局部和全身反应，不需作任何处理，经适当休息即可恢复。若反应严重者，应密切注意观察，必要时进行医治。极个别在接种后发生过敏反应，甚至出现休克，应立即肌肉注射1/1000肾上腺素急救。

预 防 接 种 表 表 1—4

制品名称	接种季节	接种对象和方法	免疫期	禁 忌 症	保存条件
麻疹	11~12月	8个月以上未患过麻疹的易感者，皮下注射1次0.2毫升，接种时应备1:1000肾上腺素以急救之用		有支气管喘息，荨麻疹及对某种食物、药物等过敏史者；正在发热或患急性疾病，患白血病及其它严重疾病者（如三度佝偻病，活动结核、中耳炎、肾炎等）正在施行放射或激素治疗者	2~10℃ 在室温22℃以上不超过2小时
小儿麻疹糖丸	12~1月	小儿自两个月即可服用，随后每年一次，连服三年，至入学前再服一次，服时先服Ⅰ型后服Ⅱ型或加Ⅲ型相隔一个月		同“精白”禁忌症（1）	4~8℃ 5个月 20~22℃ 7天
牛痘苗	普 种 11~12月 初 种 2~3月	初种两个月至一周岁及逾期未种者；每6年全民普种一次，对象是3个月~55岁	3~4年	急性传染病及恢复期，全身湿疹及蔓延性皮肤病，心、肾疾病，糖尿病，活动性结核，重症血友病，变态反应性疾病，体弱多病，经常发烧；种卡介苗后至少一个月后方可种痘；种痘后至少半个月方可接种其它制品	0~5℃
卡介苗	普 种 2~3月	二个月以内的婴儿及结核菌素试验阴性的学龄前儿童，经过普种后，每年抓1、4、7、10、14、17年龄组的复种。（1）口服法：婴儿出生后头十天，隔天一次连服三次，每次1毫升。（2）划痕法：一次，一滴。（3）皮内注射法：注一次0.1毫升	2~4年	凡有结核病，急性发热病，湿疹或化脓性皮肤病的都不可接种。接种前两周及接种后四星期内，不得作其它接种。局部反应处理见说明书	液体的保存于2~10℃，冻干的保存于冷暗处，过失效期的不可使用

制品名称	接种季节	接种对象和方法	免疫期	禁忌症	保存条件
“精白” 或 “百白”	5~6月	满3个月婴儿，“精白”基础免疫注二次，每次0.5毫升，相隔4~6周；3、7年龄组加强注射一次0.5毫升。“百白”基础免疫注射三次：0.5、1.0、1.0毫升，加强1毫升	约3年	(1)急性传染病及恢复期，心脏病代偿不全及血液病，肝、肾疾病，活动性结核，糖尿病，变态反应性疾病，痉挛素质，重症营养不良，重症消化不良。 (2)患过中枢神经系统传染病（脑炎、脑膜炎）	2~10℃
百白破 混合制剂	同上	注射对象同上，基础免疫注三次：0.5、1.0、1.0毫升，相隔4~6周，加强1.0毫升	2~3年	同上	25℃以下 冷暗处
破伤风毒素 或“精破”	5~6月	有受破伤风威胁的人，普注7~55岁注射三次：0.5、1.0、1.0毫升，相隔4~6周，一年后注射1毫升，于受伤时立即加强注射1毫升。采用“精破”注二次，每次0.5毫升，加强剂量0.5毫升	3~5年	同“精白”禁忌症 (1)	干、冷、 阴暗处
伤寒、 副伤寒 甲乙三 联菌苗		2~59岁重点对象，注三次，相隔7~10天。 剂量： 2~6岁：0.2、0.4 0.4毫升。 7~14岁：0.3、 0.6、0.6 毫升。 15岁以上：0.5、 1.0、1.0 毫升		急性传染病及其恢复期，心脏病代偿不全及血液病，肝、肾疾病，活动性肺结核，活动性风湿病，糖尿病，重症高血压，突眼性甲状腺肿，哮喘，胃或十二指肠溃疡发作期，经期（暂缓注射），孕妇，前6个月授乳母亲	干、冷、 暗处

制品名称	接种季节	接种对象和方法	免疫期	禁忌症	保存条件
多价钩端螺旋体菌苗		一般流行区：下水田或在潮湿地区工作的农、渔民及工人。重流行区：除老幼无劳动力者外应普遍注射。 注二次，第一次1.0毫升，第二次2.0毫升，7~13岁用量减半。相隔7天。每隔2年注射一次		同“乙脑”疫苗禁忌症(1)	2~8℃
人用狂犬疫苗		证明被狂犬(狂猫)咬伤抓伤者。接种方法见疫苗说明书	半年	诊断确实，应及早接种，不考虑禁忌症(急性传染病患者除外)，已发病者，接种无效	2~10℃
流行性乙型脑炎疫苗		6个月~12岁，注射二次每次剂量：6~12个月0.25毫升，1~6岁0.5毫升，7~12岁1.0毫升，相隔7~10天，第二年加强注射一次	1年	(1)同伤寒、副伤寒甲乙三联菌苗 (2)成人酒精中毒者	2~10℃

第二章 人体的基本结构和生理

毛主席教导我们：“大家明白，不论做什么事，不懂得那件事的情形，它的性质，它和它以外事情的关联，就不知道那件事的规律，就不知道如何去做，就不能做好那件事。”我们要增强体质，讲究卫生，减少

疾病，并与疾病作斗争，就必须认识人体的结构和生理机能。

人体从外形上，分成头、颈、躯干和四肢（图2—1）。身体最表面一层是皮肤（包括它下面的皮下组织），中层是肌肉，最里面是骨骼。

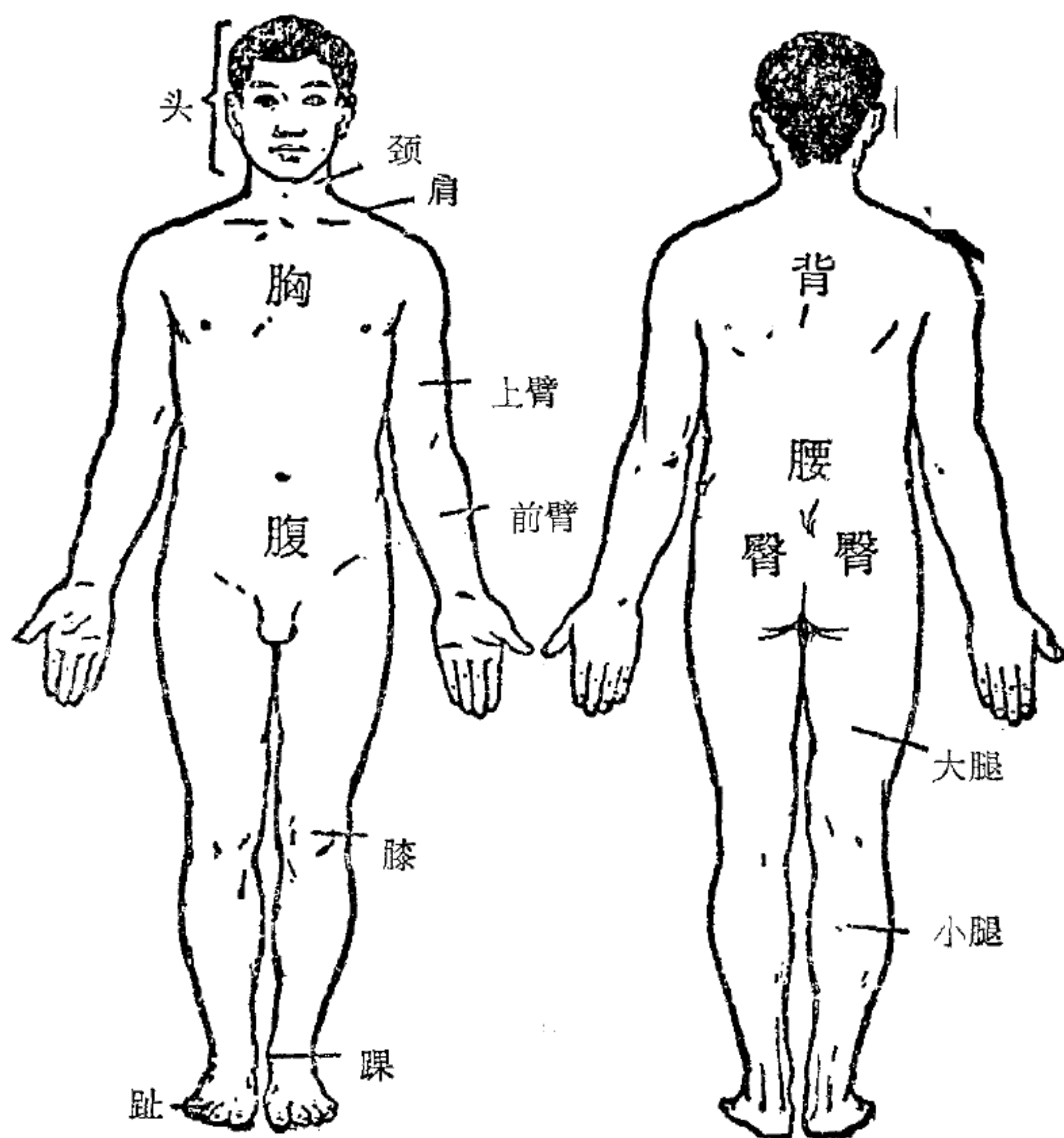


图 2 ~ 1 人体各部分名称

头部的颅腔内有脑。颈部前面可摸到喉头和气管，气管的后面是食道。躯干前面分为胸部和腹部；后面分为背部和腰部。躯干的内部由膈肌分为胸腔和腹腔。胸腔里，左右有肺，中间略靠左的地方是心脏。腹腔内有胃、小肠、大肠、胰、肝、胆囊、脾、肾和膀胱等器官（图2—2）。躯干的后壁有脊柱。脊柱是由一连串的椎骨

组成，脊柱的椎管内有脊髓，脊髓与颅腔里的脑相连。四肢是指两上肢和两下肢。上肢分上臂、前臂和手三部分。下肢分大腿、小腿和足三部分。

人体是一个复杂的统一整体。构成人体的基本单位是细胞，如神经细胞、骨细胞、肌肉细胞、血细胞等。每个细胞都有新陈代谢。由许多形态、构造和机能相同的细胞联结在

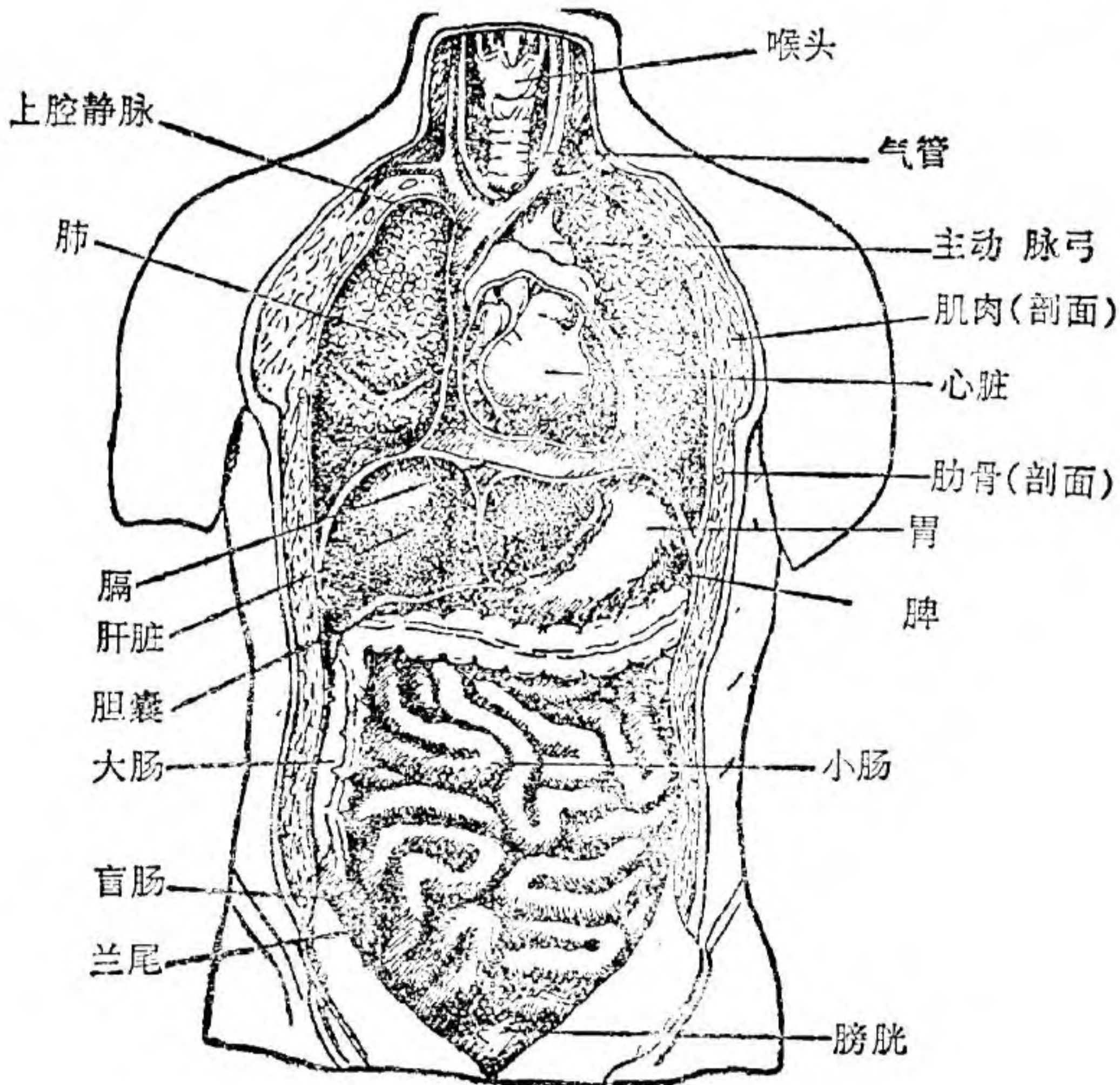


图 2 ~ 2 体腔脏器（剖面）

一起，形成组织。由几种不同的组织合起来，执行一定的功能，叫做器官，如心、肺、胃、脑、眼等。几种器官联合起来，互相协作，共同完成一个任务，称系统，如鼻、咽、喉、气管、支气管和肺等器官，连成一起，共同担任呼吸工作，叫做呼吸系统。此外还有循环、运动、消化、泌尿、神经、感觉、内分泌、生殖等系统。人体里的每个器官和系统的功能虽各有不同，但都是在神经系统的指挥下，彼此联系和相互影响，共同完成人体的全部生命活动。因此，人体是一个完整的统一体。

毛主席教导我们：“一切事物中包含的矛盾方面的相互依赖和相互斗争，决定一切事物的生命，推动一切事物的发展。”人体所以有生命活动，就是由于存在着物质的组成和分解这一对矛盾的相互依赖和斗争。身体不断把从外界吸收来的物质组成它自己的组织，同时又不断分解自己的物质，并把物质分解后产生的一些废物，如二氧化碳等，排到体外去，这就是新陈代谢。正因为身体这样不断地进行新陈代谢，才表现出它的生命活动，如果新陈代谢一停止，生命也就结束。

第一节 运 动 系 统

运动系统由骨骼和肌肉组成。在人体内起着保护、支持和运动等的作用。

骨 骼

人体的骨骼由大小共206块骨头组成。骨骼分为头颅骨，躯干骨和四肢骨(图2—3)。骨和骨连接的地方，叫做关节(图2—4)。骨的构造，由骨膜、骨质和骨髓组成(图2—5)。骨的功能有支持身体，保护内脏和脑，完成身体各种运动(靠附着在骨头上的肌肉收缩)

以及红骨髓制造血球等作用。

主要骨骼的部位和名称

1. 头颅骨：大部分为扁平骨。由额骨、顶骨、枕骨、颞骨等直接连合构成球形空腔，称颅腔(保护大脑)。只有下颌骨有关节，才能活动。新生儿(18个月内)由于骨化较慢，额骨与顶骨还没有完全闭合(形成前囟)，脑膜炎时前囟会突起。

2. 脊柱：由颈椎(7块)、

胸椎(12块)、腰椎(5块)、骶骨和尾骨等所组成。第七颈椎在屈颈时明显突出,可作为计算椎骨的标志。每个椎骨中间有一个椎孔,椎骨迭在一起,形成一条椎管,管中装有脊髓,如果脊椎骨折断时损伤了脊髓,就可能发生双下肢瘫痪。

3.胸廓:由胸骨(其下端在“心窝”部成为剑突),肋骨(12对),和胸椎组成。胸廓前壁下缘叫肋弓。胸廓能保护胸内的心、肺等脏器,并对呼吸运动有重要作用。

4.骨盆:由左、右髌骨、骶骨和尾骨组成。

5.上肢骨:每侧有锁骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨和手骨。

6.下肢骨:每侧有髌骨、股骨、髌骨、胫骨、腓骨和足骨(图2—3)。

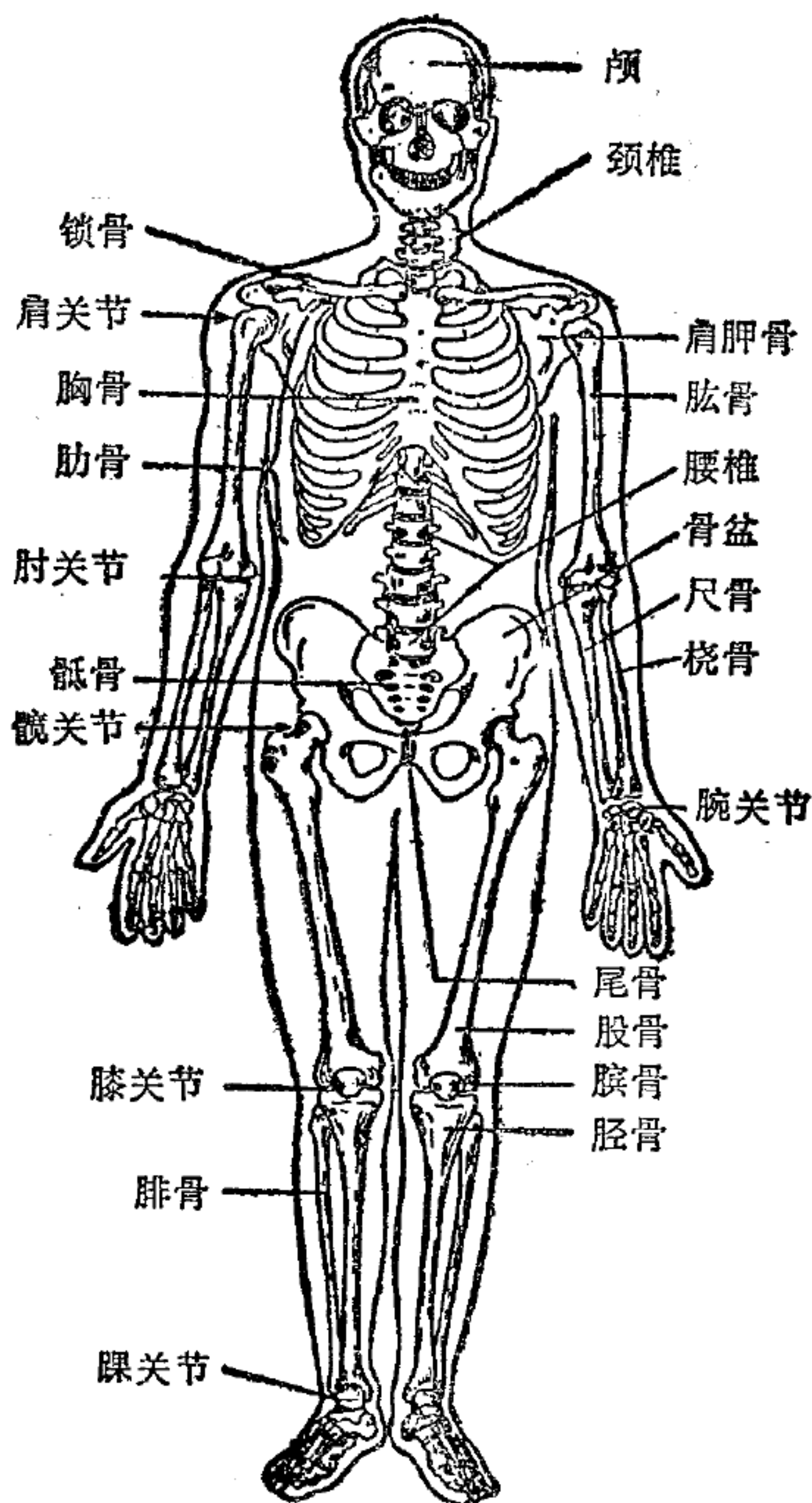


图 2 ~ 3 人的骨骼

关 节

骨与骨之间通过韧带间接连接,留有空腔,容易活动叫关节。在强力作用下会脱位(脱臼)。一个关节有关节囊、骨关节面和关节腔几个部分(图2—4)。关节腔内有少量滑液,便于关节活动。

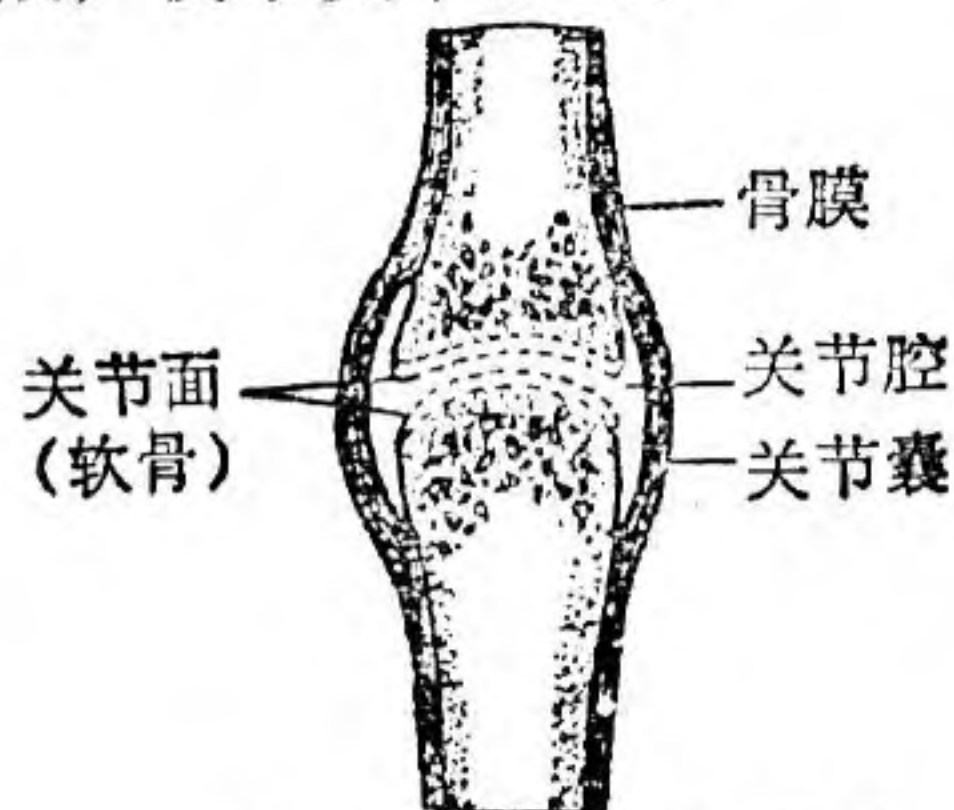


图2~4 关节的构造

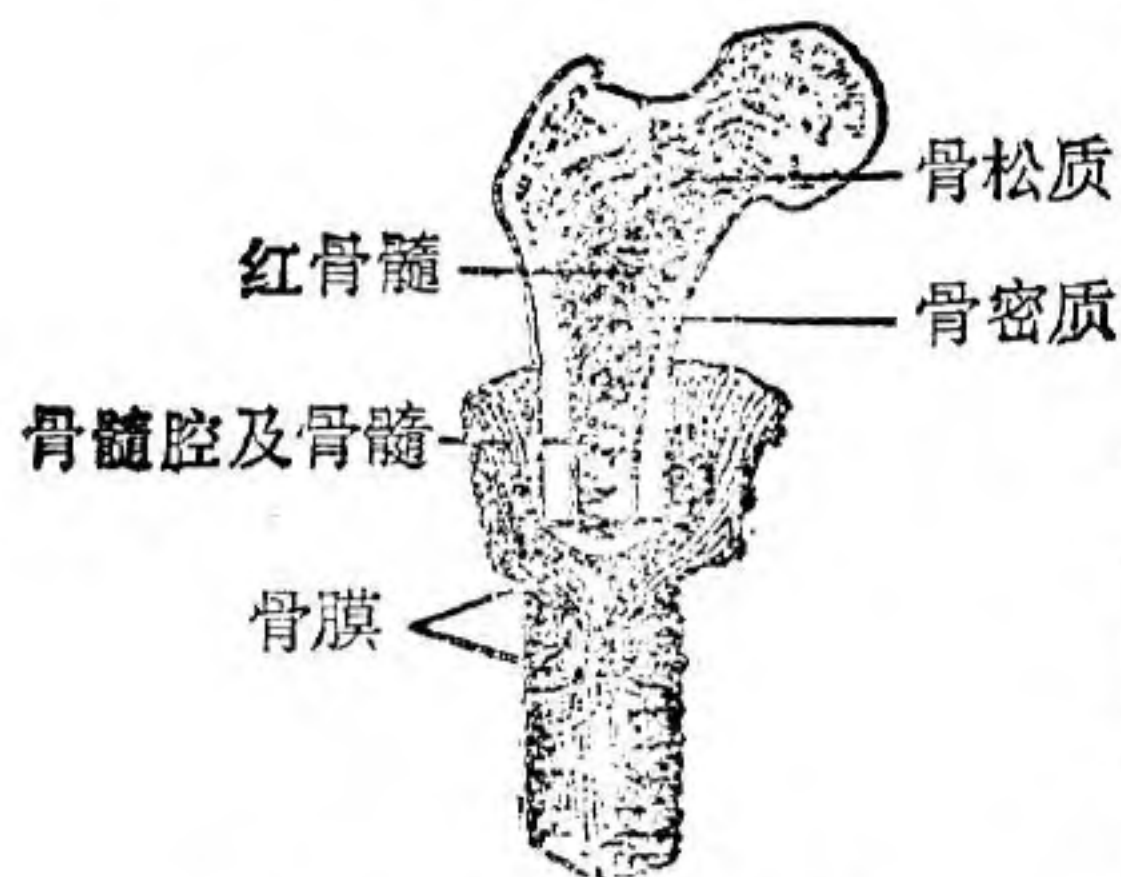


图2~5 骨的构造

全身主要大关节有:

1. 头部: 下颌关节、头颈关节。
2. 上肢: 肩关节、肘关节、腕关节。
3. 下肢: 髋关节、膝关节、踝关节(图2—3)。

肌 肉

人体的肌肉分为心肌、平滑肌和骨骼肌三种。心肌是构成心脏的特有肌肉;平滑肌主要为组成血管、胃、肠、食管、膀胱、子宫等内脏壁的肌肉,这两种肌肉不随人的意志收缩。骨骼肌绝大部分附着在骨骼上,能随人的意志主动收缩。骨骼肌收缩时牵引骨骼,而产生运动。我们日常劳动、工作和说话等,实际上都是肌肉牵引骨骼活动的结果。

人体主要的浅表骨骼肌的部位和名称见(图2—6)(图2—7)。这些肌肉中常作注射用的有臀大肌、三角肌,因为它们大块而厚,血管和神经位置较深,不易被注射器的针头所穿刺到。

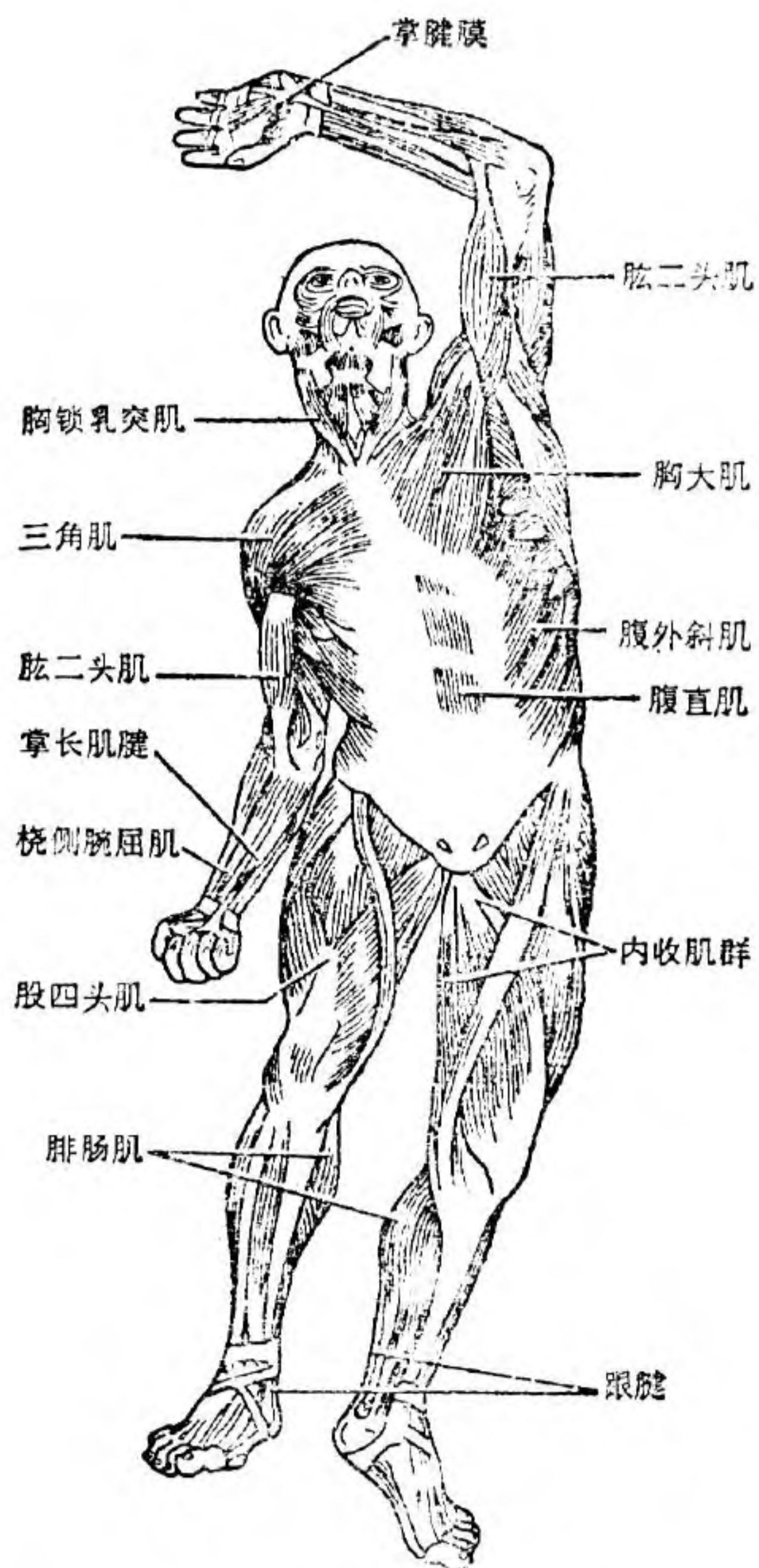


图 2 ~ 6 人体浅层肌肉 (前面)

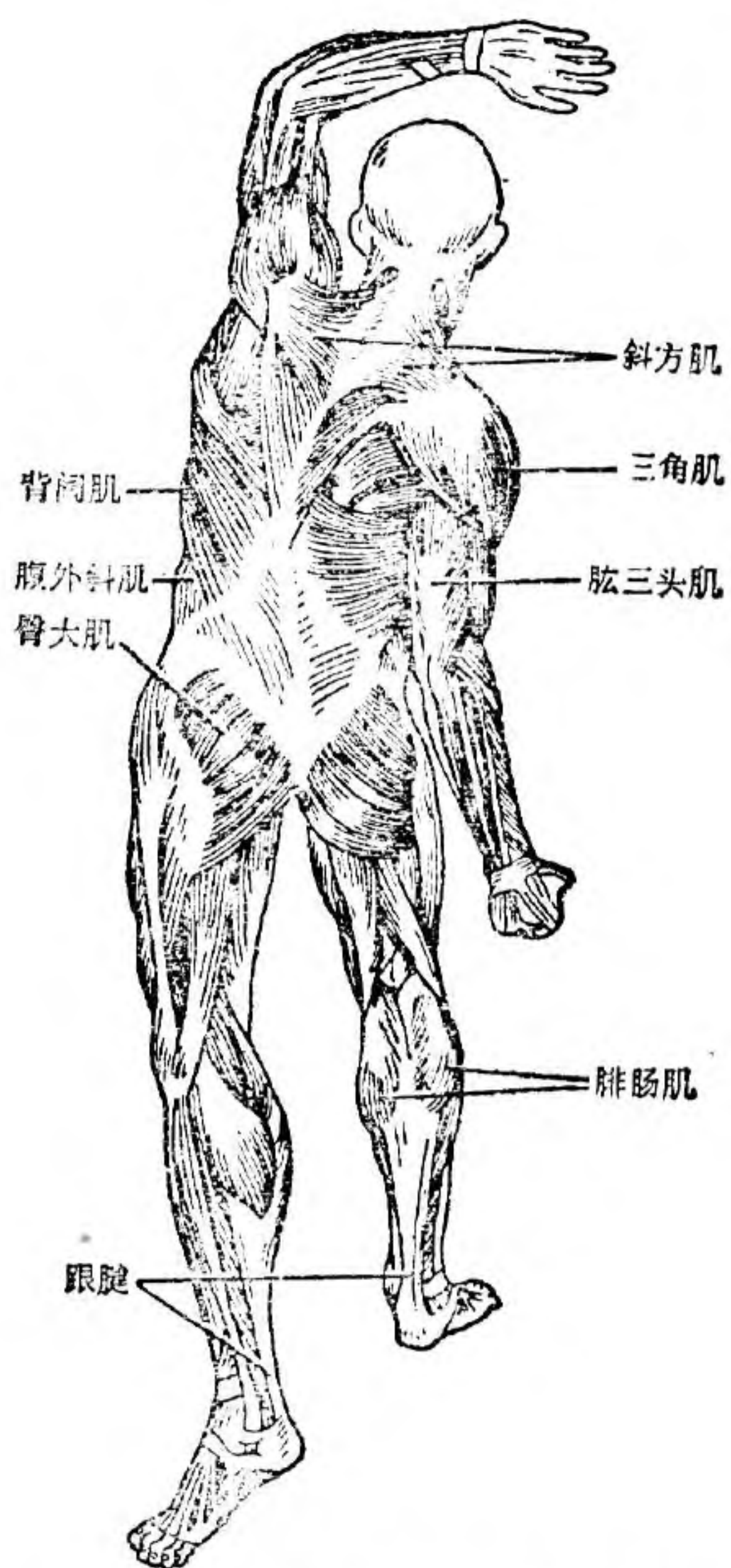


图 2 ~ 7 人体浅层肌肉 (背面)

第二节 循环系统

循环系统包括血液循环系统和淋巴循环系统。它的主要功能是把养料和氧气输送到全身各个组织器官，并将各个组织器官所产生的废气和废物运送到排泄器官(肺、肾、汗腺等)，排出体外。

血液循环系统

是由血液，心脏和血管组成。

一、血液：血液是在心脏和血管内流动的液体。全身血液约占人体重量的7—8%，血量太少会引起血液循环障碍，因此出血病人应迅速采取止血措施，必要时需输血和补液。血液的主要成份是血浆和血球。血浆占血液的50—60%，血浆主要是水份，里面有蛋白质、脂肪、葡萄糖和电解质(如钠、钾、钙等)。正常时，体内水和电解质的吸收量和排出量基本上保持平衡，当呕吐、腹泻、烧伤等，使水份和某些电解质损失过多，就会引起平衡失调，出现一些严重症状，必须及时纠正(补充液体等)。血球占血液的40—50%，分红血球、白血球和血小板。

1.红血球：无核，内含血

红蛋白，它能带氧气和二氧化碳，完成气体交换。动脉中的血红蛋白含氧较多，所以动脉血的颜色是鲜红的；静脉血中的血红蛋白含氧较少，使血颜色变暗红。当呼吸困难时的病人，因吸进的氧不足，血液颜色变深，口唇和皮肤都显出青紫色，叫做发绀。正常成人男性每立方毫米血液中有450—550万个，女性约有380—500万个，100毫升血中正常男性含有血红蛋白11.5—15.5克，正常女性含9.6—12.5克。

2.白细胞：有核，能吞噬细菌、病毒，保护机体，参与机体免疫反应。正常成人，每立方毫米血液中有5000—10000个白细胞，当发炎发热时(如阑尾炎)白细胞总数增加。

3.血小板：形态不定，易破裂(出血时)，能促进血液凝固，有止血作用。正常人每立方毫米血液中有血小板10—30万。

4.血型：人的血型分成O、A、B、AB四种类型，如果输入的血液和病人的血型不合，会造成严重的后果甚至死亡，故输血前必须先检验血型。

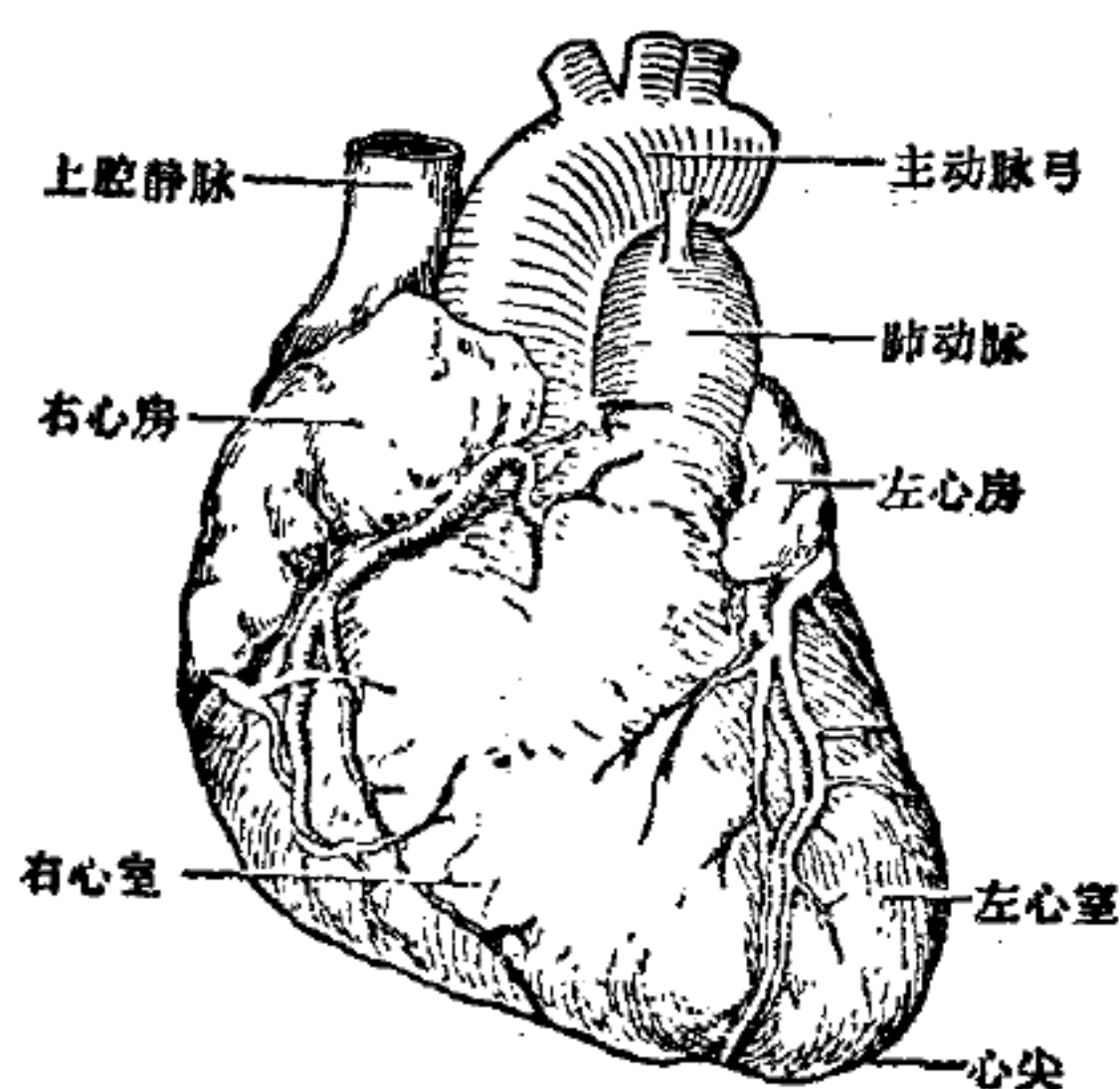


图2~8 心的前面

二、心脏（图2—8）

心脏位于胸腔内正中线的偏左方，约等于自己的拳头大小，似锥形。心脏由心肌构成。心脏内面有心内膜，外面有浆膜包着，称“心包”。心腔分为右心房、右心室、左心房、左心室四个腔。右心房与右心室之间有三个瓣膜构成活门，称三尖瓣；左心房与左心室间有二个瓣膜构成活门，称二尖瓣。左右心室和动脉之间各有三个半月瓣膜构成活门，分别称为主动脉瓣和肺动脉瓣。

1.右心房：与上下腔静脉相连通，接收全身回流到心脏血液。

2.右心室：与右心房相通，又与肺动脉相接，接收右心房来的血；将血压入肺动脉。

3.左心房：与肺静脉相通，

接收由肺静脉回流到心脏带氧气的血。

4.左心室：与左心房相通，又与主动脉相接，接收左心房来的血，将血压入主动脉（图2—9）。

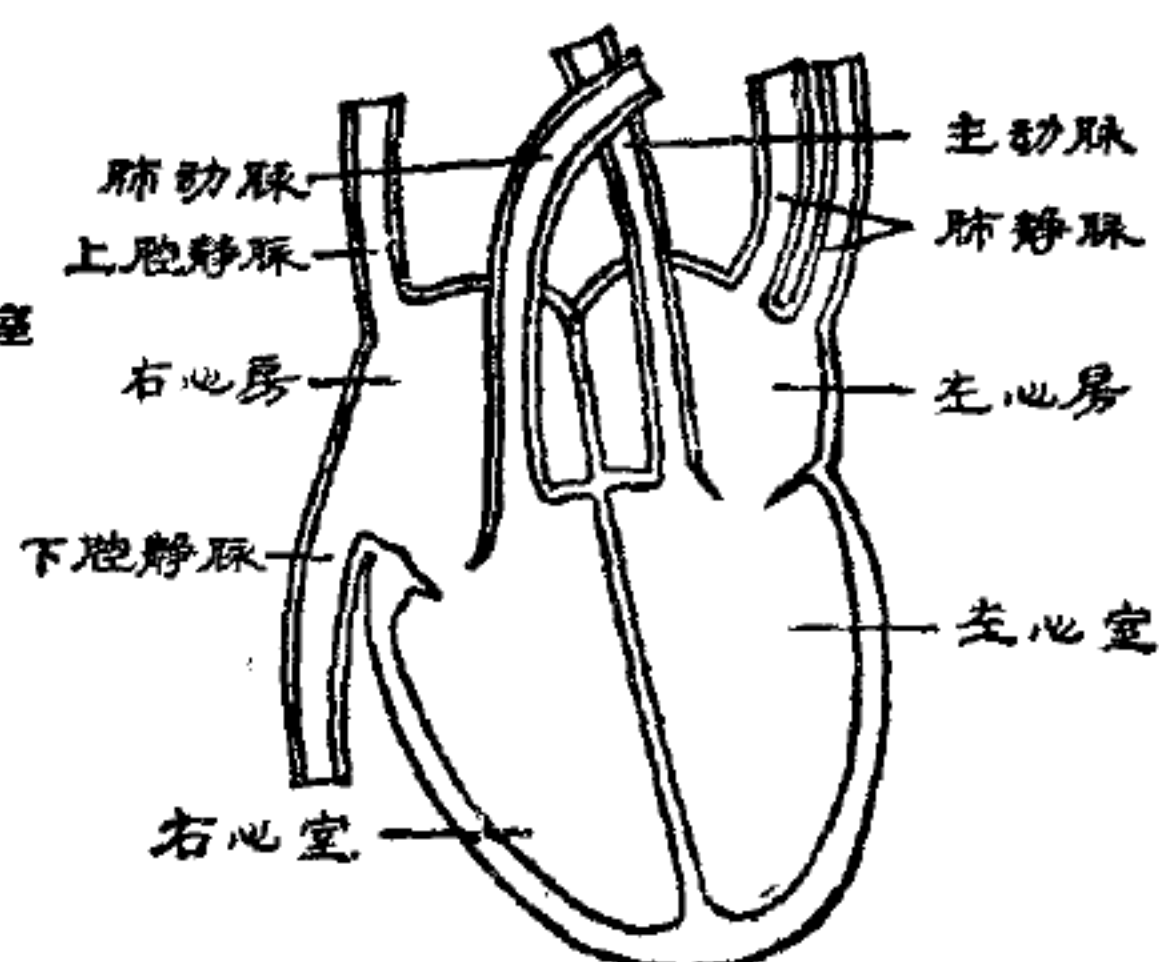


图2~9 心脏纵切面示意

三、血管：

血管与心脏相通，是无数大大小小互相连通的管子，满布全身，可分动脉、静脉、毛细血管三种。从心脏输出血液的血管叫动脉（管壁较厚，富于弹性）。它越分越细，最后变成极细的毛细血管（管壁薄，血液在此进行物质交换）。输送血液回心脏的血管，叫静脉（管壁较薄，弹性较小，管内有瓣膜）。由毛细血管汇集全身的血液，流入小静脉，小静脉越合越大，最后合成大静脉通入心脏（图2—10）（图2—11）。

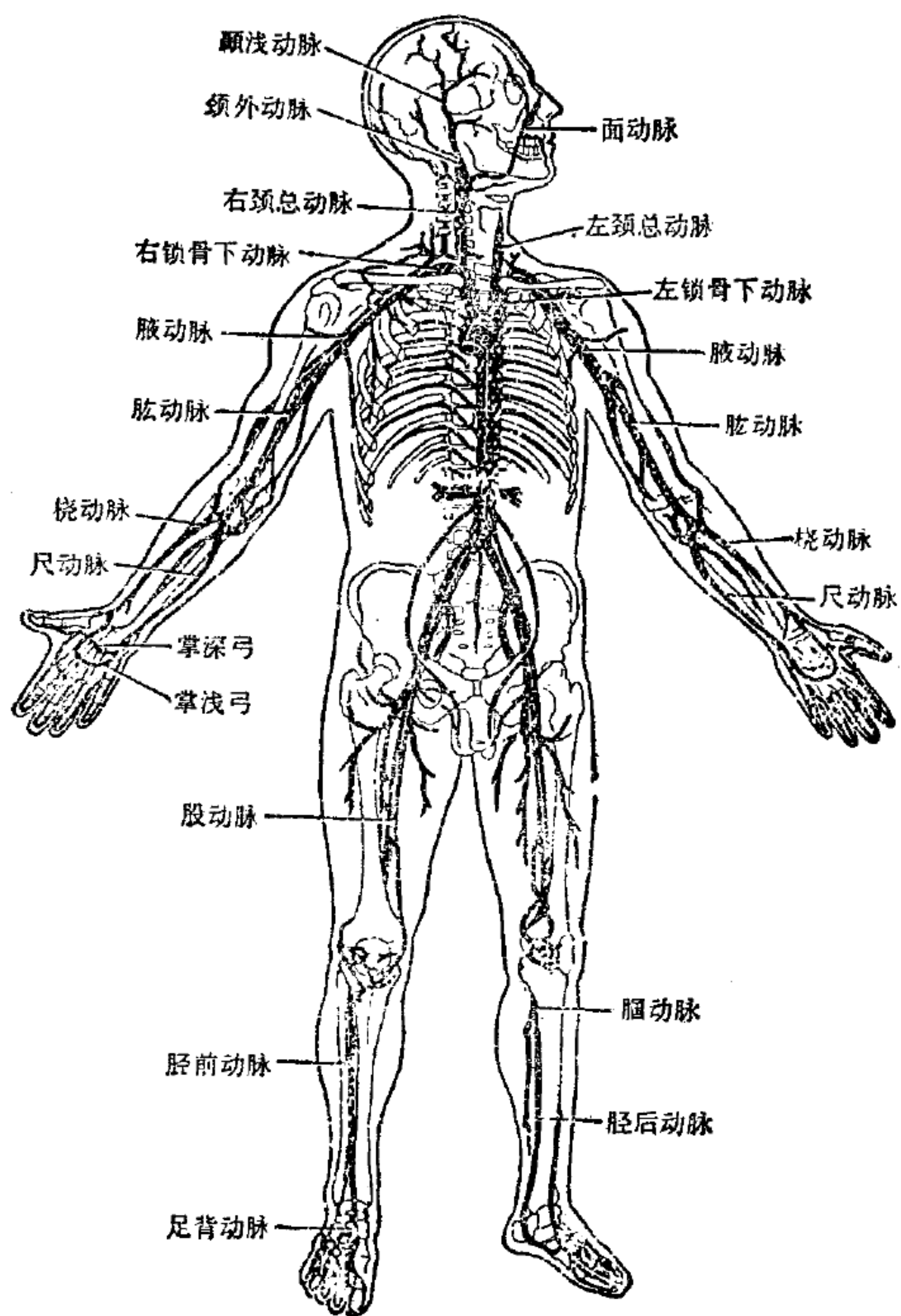
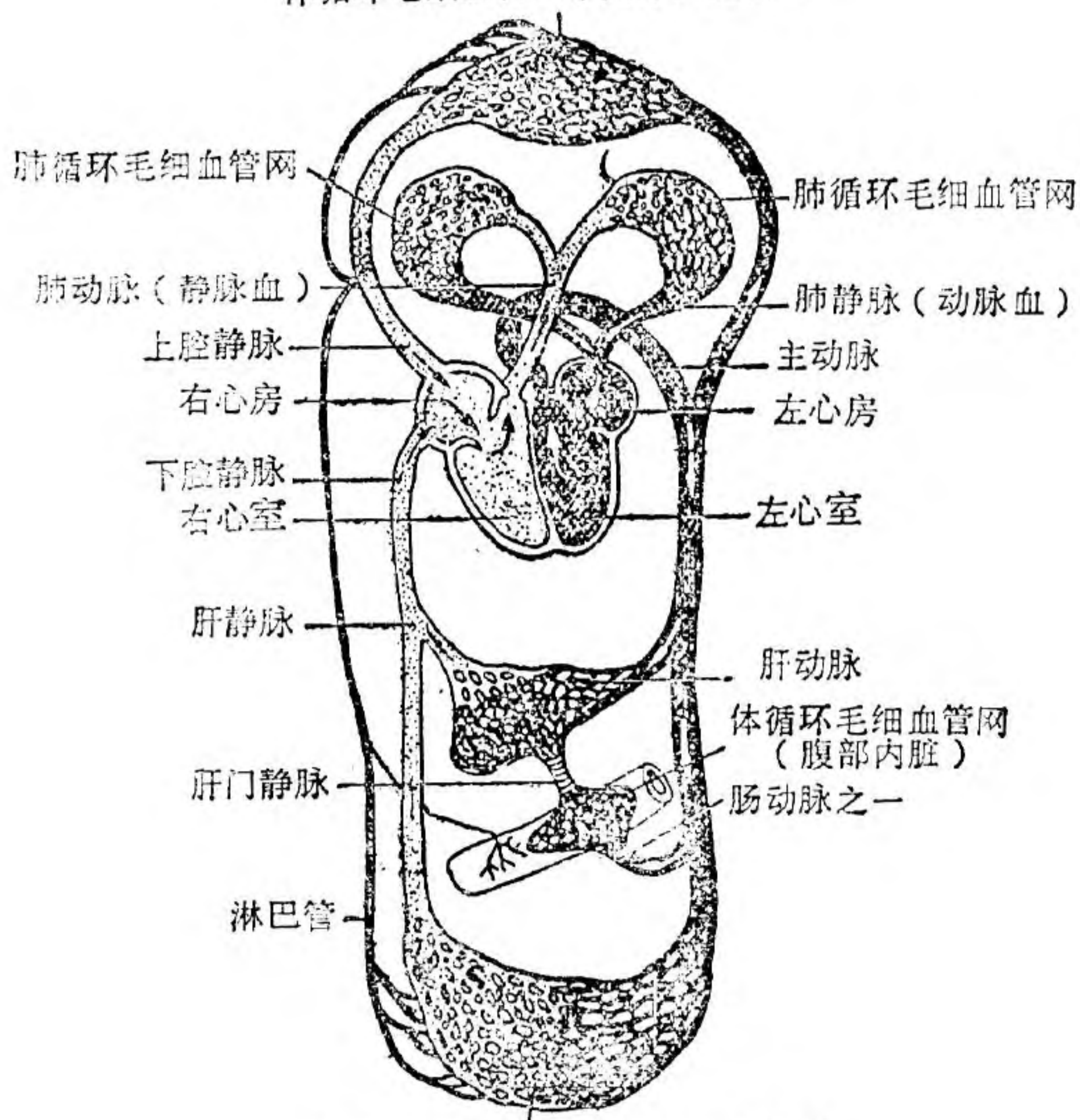


图2~10 全身主要的动脉

体循环毛细血管网（头部、上肢）



体循环毛细血管网（腹部、下肢）

图2~11 全身主要静脉

四、血液循环的途径

1. 体循环又叫大循环：血液由左心室进入主动脉，经过身体各处的动脉、毛细血管、静脉，最后由上、下腔静脉流回右心房完成体循环。

2. 肺循环又叫小循环：血液由右心室进入肺动脉，通过肺毛细血管网，进行气体交换，吸收新鲜氧气，排出二氧化碳，最后由肺静脉流回左心房，完成肺循环（图2—12）。

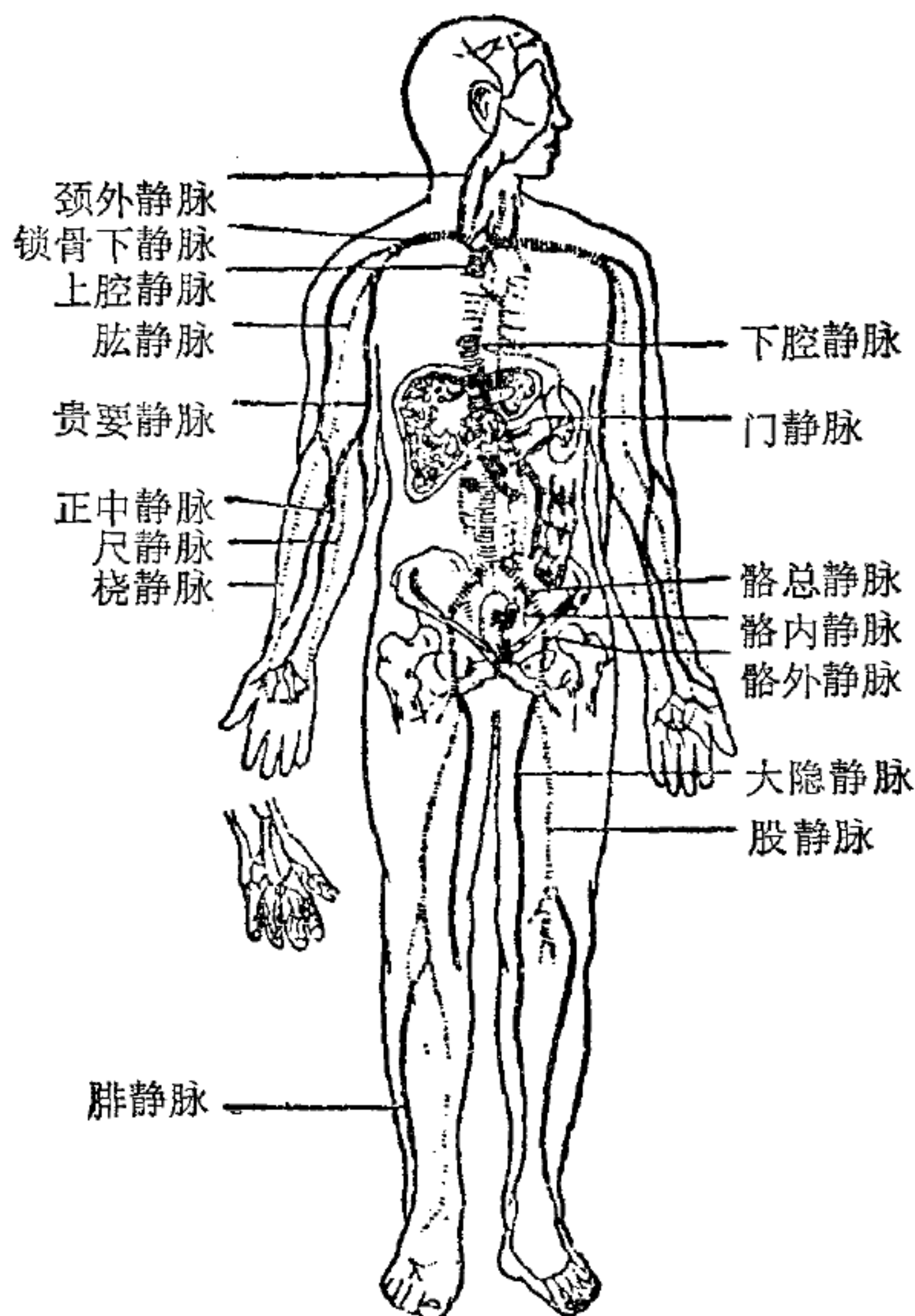


图2~12 循环途径模形图